

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ESPECIAL-LOGOPEDIA

MATERIAL DOCENTE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: Folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

AUTOR: Lic. Liana Cisneros Rivero.

TUTORES: Dr. C. Ángel Bravo Rodríguez. PT

Dr. C. Miriam Duany. Timosthe. PT

2023

DEDICATORIA:

A mi familia por ayudarme a este nuevo reto en mi vida profesional y laboral y en especial a mi hija por ser el motor impulsor cada día que me inspira a seguir adelante, a superarme.

Agradecimientos:
A mi familia, por su inmenso amor, su apoyo y su comprensión, fuente de
Inspiración para vencer las dificultades.

A los Dr. C Ángel Bravo Rodríguez, Dr. C. Miriam Duany Timosthe, Dr. C. Félix Huepp Ramos, quienes han sabido guiarme sin escatimar tiempo ni esfuerzos en mi formación profesional; al Dr. C. Joaquín Pérez Peralta por toda la sapiencia demostrada desde la Metodología de la Investigación. A la M. Sc. Adis Regalado Caballero, por su apoyo incondicional cuando más lo necesité.
A mis compañeros de la maestría, por estar siempre unidos para el logro de nuestros objetivos.
A todos ***Muchas Gracias.***

SÍNTESIS.

La presente investigación aporta un folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia en la escuela primaria “José Julián Martí Pérez” de modo que contribuya al proceso en aras de elevar la calidad de la atención logopédica en los educandos del primer ciclo. Se precisa como objeto de investigación el proceso de atención de los trastornos del lenguaje y la comunicación. El campo de acción lo constituye**,** la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos. Tiene como objetivo la elaboración de un folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos portadores de rinolalia. Para alcanzar el objetivo de la investigación se emplearon métodos del nivel teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos, que contribuyeron al conocimiento del estado actual y determinar los cambios que se han alcanzado en la muestra de educandos con rinolalia. La novedad científica se revela en el aporte de un folleto de actividades de orientación logopédica para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje a educandos con rinolalia, desde un enfoque holístico, que incida en el fomento de una mejor participación de este componente al desarrollo del lenguaje.

Palabras claves: atención logopédica, componente sonoro del lenguaje, rinolalia.

SYNTHESIS.

The present investigation provides a brochure for speech therapy care to the sound component of language in students with rhinolalia in the "José Julián Martí Pérez" primary school in order to contribute to the process in order to raise the quality of speech therapy care in students of the first year cycle. The process of attention to language and communication disorders is specified as an object of investigation. The field of action is constituted by logopedic attention to the sound component of language in rhinolalic students. Its objective is the elaboration of a brochure for logopedic attention to the sound component of language in students with rhinolalia. To achieve the objective of the investigation, theoretical, empirical and mathematical statistical methods were used, which contributed to the knowledge of the current state and to determine the changes that have been achieved in the sample of students with rhinolalia. The scientific novelty is revealed in the contribution of a brochure of speech therapy orientation activities for speech therapy attention to the sound component of language for students with rhinolalia, from a holistic approach, which affects the promotion of a better participation of this component in the development of speech. language.

Keywords: speech therapy care, sound component of language, rhinolalia.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

Epígrafe 1: Diagnóstico del estado actual de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia..... 7

Epígrafe 2: Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos..... 9

2.1: Fundamentos del proceso de atención logopédica. 9

2.2. El componente sonoro del lenguaje, sus particularidades en los educandos con rinolalia..... 13

2.3: Fundamentos del proceso de atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia..... 19

Epígrafe 3: Folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia. 27

3.1 Fundamentación del folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia. 27

3.2: Presentación de la estructura y contenido. 29

Epígrafe 4: Valoración de la pertinencia, factibilidad y efectividad del Folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia. 46

CONCLUSIONES..... 54

RECOMENDACIONES 55

INTRODUCCIÓN

La educación se enfrenta hoy a cambios radicales en su modelo educativo en el contexto histórico social del perfeccionamiento del socialismo cubano, que reclama un nuevo estilo de trabajo del maestro y la escuela, donde se atienda la individualidad de cada niño y se lleve a niveles superiores los resultados de la labor educativa.

> hoy se trata de perfeccionar la obra realizada, partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educativo que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear. (Castro Ruz, 1987, p. 3)

La escuela tiene el encargo de favorecer el proceso de formación de los niños a partir de las exigencias culturales y los niveles de desarrollo que estos hayan alcanzado. Sin embargo, todos los niños no aprenden igual y algunos presentan dificultades para aprender, por lo que precisan una atención diferenciada. Uno de los problemas que se identifican con más frecuencia son los relacionados con el desarrollo del lenguaje. Estos en ocasiones se presentan asociadas a otras necesidades educativas especiales o pueden generarlas.

Las instituciones educativas despliegan acciones en función del desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, responsabilidad que comparten docentes y familias en unidad al logopeda al conformar las influencias y experiencias de comunicación, las que se legitiman en las experiencias que se despliegan para que estos puedan expresar sentimientos, deseos e ideas, comprender las intenciones y mensajes; reproducir y recrear algunos textos, utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, con el empleo de las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales extralingüísticas al ajustarse a los diferentes contextos lingüísticos y situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes interlocutores.

De igual forma es la escuela y la familia como institución social objeto de cambios y transformaciones, independientemente de esto, ambas deben de propiciar que los educandos se desarrollen de manera adecuada, para ello se requiere un proceso educativo que facilite por su carácter desarrollador en su personalidad, como sujetos independientes protagonistas de su desenvolvimiento y progreso con relación a sus logros y su crecimiento personal.

Lograrlo solo será posible si ponemos nuestros conocimientos y experiencias como educadores en función del desarrollo y la educación; para ello juega un papel fundamental la comunicación del educando con sus semejantes. El Dr. Cabanas define "la comunicación humana como la capacidad codificadora y decodificadora, para formar intencional y confesionalmente un mensaje visto como un acto en que el mensaje del codificador es recibido y descifrado o decodificado" (Cabanas Comas, 1980, p. 14).

En la práctica educativa encontramos educandos con diversas particularidades en su desarrollo, tal es el caso de aquellos con trastornos del lenguaje y la comunicación, los cuales precisan de una atención temprana en aras corregir y/o compensar las alteraciones que puedan presentarse. El éxito de esta atención depende de la realización de un diagnóstico y evaluación que permita caracterizar de manera profunda los disturbios que presenta el educando, determinar la patología en correspondencia con los resultados del diagnóstico y concebir la estrategia de intervención según corresponda.

La investigación centra su atención en el proceso de atención logopédica que en el contexto educativo se realiza con aquellos escolares que presentan en el área del lenguaje y la comunicación algún disturbio, toda vez que en este proceso se están produciendo cambios significativos para la concepción y organización de la intervención logopédica. Estos están íntimamente vinculados con las nuevas concepciones en la pedagogía y en la educación, y en la Logopedia como ciencia en particular.

En Cuba la atención logopédica se concibe por el Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 160/81, la que norma la prevención primaria, secundaria y terciaria; la educación y rehabilitación del lenguaje; y los enfoques preventivo, comunicativo y de inclusión educativa, los cuales guían la atención que se les brinda a los escolares del nivel primario.

El periodo correspondiente a este nivel educativo constituye un momento trascendental en los procesos de maduración relacionados con el lenguaje y los procesos psíquicos en general, además constituye una de las etapas fundamentales tanto para las adquisiciones y desarrollo de potencialidades de los escolares, como para la aparición de alteraciones en el desarrollo, pues en este momento se definen los trastornos del lenguaje más frecuentes como las dislalias, los retrasos del lenguaje, la tartamudez y las manifestaciones de dislexias y disgrafias, entre otras.

En la literatura especializada, la atención logopédica ha sido abordada por: Martín, M. y otros (1986), Figueredo, E. y López, M. (1984), (1986), Pérez, E. (2002), Calzadilla, O. (2003), Morales, M. E. (2004), Fernández, G. (2006, 2008) y Cobas, C. (2006), Noguera, K. (2008), Chernousova, L. (2008),

Lores, I. (2013). Estos autores profundizan en los diferentes trastornos del lenguaje y la comunicación al aportar sistemas de procedimientos, métodos y la concepción de atención a entidades logopédicas particulares.

No obstante, los resultados dejan evidente la carencia del tratamiento teórico y metodológico al proceso de atención logopédica, con una visión global que conciba la integración de este especialista al proceso pedagógico y del resto de los agentes al proceso de atención logopédica. En este sentido se considera que los enfoques actuales de la atención logopédica promueven las relaciones de integración entre los agentes educativos y la participación de los especialistas de la medicina en el proceso preventivo, correctivo – compensatorio de los trastornos del lenguaje y la comunicación, sin embargo, se carece de fundamentos que sustenten dichas relaciones en el campo pedagógico.

La atención educativa a los niños que presentan necesidades educativas especiales en el área del lenguaje se ha convertido en los últimos años en centro del debate acerca de cuál deberá ser el procedimiento a seguir para su corrección y/o compensación. La autora de esta investigación, interesada en esta temática presenta aquí las consideraciones teóricas y metodológicas que rigen la práctica educativa de esta problemática y una propuesta que por su pertinencia y factibilidad puede ayudar a construir una perspectiva diferente para la intervención en la práctica logopédica y en particular en escolares con rinolalia.

El diagnóstico, evaluación y tratamiento en caso de rinolalia, dada la complejidad de esta patología precisa de una intervención multidisciplinar. Siendo necesario la concepción de técnicas novedosas que permita una exhaustiva caracterización de los tres componentes del lenguaje y en correspondencia, una eficaz atención a las alteraciones que se derivan de esta logopatìa verbal fundamentalmente del componente sonoro del lenguaje.

Numerosas son las investigaciones sobre la rinolalia en el contexto internacional, y en particular en el proceso de evaluación y diagnóstico del componente sonoro del lenguaje siendo recurrentes, estos investigadores, en el análisis y énfasis de la necesidad de una correcta y profunda evaluación y diagnóstico del cuadro sintomatológico de los educandos portadores de rinolalia.

En Cuba, los educandos diagnosticados con rinolalia, en algunos casos son operados y rehabilitados, sin embargo no tienen el éxito deseado en este proceso, que desde la percepción de la autora las fallas radican en el diagnóstico realizado al no profundizarse en la evaluación del aspecto sonoro suficientemente. Además se observa que no se utilizan técnicas variadas para caracterizar estos

educandos. Siendo necesario un manual de técnicas que contribuyan a favorecer el diagnóstico y evaluación del aspecto sonoro en los educandos rinolálicos.

En la escuela José Julián Martí Pérez del Municipio Songo–La Maya se corrobora en el tratamiento a educandos rinolálicos las siguientes insuficiencias:

-Poca profundidad en el tratamiento al componente sonoro del lenguaje en los educandos con rinolalia.

-Insuficiente variabilidad de actividades para la evaluación y diagnóstico del componente sonoro del lenguaje.

-Poco aprovechamiento de las potencialidades que brinda la exploración logopédica durante el proceso del diagnóstico del componente sonoro del lenguaje en los educandos con rinolalia.

Por los argumentos anteriores se define como **problema científico** de la investigación; ¿Cómo fortalecer el proceso de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia? En correspondencia con ello se identifica como **objeto de investigación:** el proceso de atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación; se formula como **objetivo de la investigación:** elaboración de un folleto para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos. Se delimita como **campo de acción**: la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos. Se propone como **tema de la investigación:** folleto para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educando con rinolalia.

Para la solución del problema científico y dar cumplimiento al objetivo antes declarado se plantean las siguientes preguntas científicas.

Preguntas científicas:

1. ¿Cuál es el estado actual de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos?
2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenta el proceso de atención logopédica de los trastornos del lenguaje y la comunicación, en particular la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos?
3. ¿Cómo fortalecer el proceso de atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia?
4. ¿Cómo evaluar la factibilidad y pertinencia de la propuesta?

Para dar cumplimento al problema científico planteado se definen las siguientes **tareas científicas:**

1. Diagnosticar el estado actual del proceso de atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.
2. Fundamentar teóricamente el proceso de atención de los trastornos del lenguaje y la comunicación, enfatizando en la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.
3. Elaborar un folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.
4. Valorar la pertinencia y factibilidad de la propuesta.

En la investigación se asume el enfoque integral de los métodos y técnicas de la investigación científica y como método fundamental el dialéctico – materialista que contribuyen al fundamento teórico- metodológico de esta investigación.

Declarándose como métodos:

Métodos del nivel teórico.

- **-Análisis-síntesis:** se utilizó durante toda la investigación para fundamentar teórico y metodológico el proceso de atención de los trastornos del lenguaje y la comunicación, enfatizando en la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.
- **Inductivo – deductivo:** permitió la identificación de elementos teóricos y prácticos del objeto de estudio para la elaboración de deducciones en la solución del problema planteado.
- **-Modelación:** se utilizó para la determinación de los componentes de las técnicas que se fueron adecuando y construyendo acorde a las concepciones, intereses, expectativas, necesidades y su vínculo con la práctica.

Métodos Empírico:

Observación a clases: para constatar el desarrollo del componente sonoro del lenguaje alcanzado en educandos con rinolalia y los métodos empleados en el tratamiento logopédico.

Entrevista a logopedas de instituciones educativas: con el objetivo de evaluar los diferentes métodos que se aplican para el tratamiento al componente sonoro del lenguaje a los educandos con rinolalia.

Pruebas Pedagógicas: a través de la exploración logopédica con el objetivo de evaluar y diagnosticar las particularidades del componente sonoro en escolares rinolálicos.

Criterio de especialistas: para la evaluación la pertinencia y factibilidad del folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

Métodos Estadísticos.

-Matemáticos: se emplea el cálculo porcentual para tabular los resultados obtenidos a través de los métodos aplicados durante la investigación, así como la presentación de los resultados del diagnóstico inicial y la evaluación cualitativa de la propuesta por los especialistas.

Población y Muestra.

Para la presente investigación se escogió como población el Seminternado José Julián Martí Pérez del municipio Songo- La Maya con una matrícula de 489 educandos y se escoge como muestra intencional dos educandos portadores de rinolalia, que cursan el segundo grado y tienen como particularidad marcadas alteraciones en el componente sonoro del lenguaje. Se trabajará además con cinco (5) logopedas que laboran en diferentes escuelas del municipio.

Significación práctica: radica en que se aporta un folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia, que contribuirá al enriquecimiento del trabajo logopédico a estos infantes.

La novedad científica se revela en el aporte de un folleto contentivo de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje a educandos con rinolalia, desde un enfoque holístico, que incida en el fomento de una mejor participación de este componente en el desarrollo del lenguaje.

La actualidad de la investigación se concreta al estar asociada al Proyecto de Investigación de la Universidad de Oriente "Inclusión social y educativa de niños adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en Santiago de Cuba", que fue financiado por el Programa Sectorial del Ministerio de Educación "Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de desarrollo. También se asocia a la Línea 1.3 de la Maestría en Atención Logopédica Integral referida a: "La didáctica para la atención logopédica".

La tesis está estructurada en síntesis, introducción, desarrollo con dos epígrafes, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y cuerpo de anexos.

DESARROLLO

Epígrafe 1: Diagnóstico del estado actual de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

La investigación se realiza en el Seminternado José Julián Martí Pérez del consejo popular "La Maya Este" ubicado en la provincia de Santiago de Cuba. Esta institución educativa cuenta con un universo constituido por 489 educandos, se escoge como muestra intencionalmente a dos educandos por ser los que presentan rinolalia, objeto de nuestro interés.

Para la realización del diagnóstico tomamos en consideración los siguientes indicadores:

1. Nivel de desarrollo del componente sonoro del lenguaje en los educandos con rinolalia.
2. Nivel de conocimiento de los logopedas sobre la atención logopédica a los trastornos del lenguaje y la comunicación y en particular el componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.
3. Efectividad del tratamiento logopédico en correspondencia con el diagnóstico.

Resultados de la entrevista a logopedas, observación a clases y la prueba pedagógica.

Resultados de la entrevista a logopedas:

El objetivo que se persigue es valorar las diferentes actividades que se realizan para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje de los educandos con rinolalia y la efectividad de estas en el proceso correctivo compensatorio.

En la entrevista realizada a los logopedas (ver anexo 1), se pudo constatar que estos tienen 5 años de experiencia docente. El 100 % plantea que realizan diferentes actividades para el tratamiento de los educandos con rinolalia pero estas se realizan de forma aislada, considerando que la poca efectividad en la corrección de este componente radica en estas insuficiencias, por lo que sugieren que se realicen otras actividades de forma integradas para la evaluación y diagnóstico.

El 100% refirieren que las actividades existentes no son suficientes para explorar el componente sonoro del lenguaje por lo que sugieren otras que fortalezcan este aspecto tan importante en la atención de los educandos con rinolalia.

El 90% aborda que trabajan con algunas documentaciones, bibliografías del logopeda en la planificación del tratamiento logopédico y no así en la exploración logopédica, lo que es insuficiente las bibliografías para explorar el componente sonoro del lenguaje en estos educandos y llegar un diagnóstico adecuado, así como un tratamiento mucho más efectivo.

El 85% plantea que las ventajas de las bibliografías existentes, es que les sirve de material de preparación y sus limitaciones están dadas en que no son integrales y no responden a las

necesidades correctivas compensatorias del educando con rinolalia, por lo que sugieren otros materiales como por ejemplo folletos con actividades ilustrativa para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje. El 15% restante son del criterio de realizar actividades metodológicas ilustrativas de variantes de ejercicios a realizar para el desarrollo del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

Resultados a las observaciones a clases y prueba pedagógica. (Ver anexo 2 y 3)

Se realiza con el objetivo de constatar el desarrollo del componente sonoro de lenguaje en la atención a los educandos con rinolalia y valorar la pertinencia de las actividades que se aplican en este proceso de atención al tratamiento correctivo.

De las 7 clases visitadas, en 5 que representa el 50% el logopeda precisó las actividades con claridad y comprueba a través de preguntas la comprensión de la lectura de los educandos, faltándoles profundización en los ejercicios de preparación para la respiración, la voz y la pronunciación. Aspecto este que coincide con los criterios emitidos en la entrevista, referido a la falta de integración de técnicas y actividades en la atención al componente sonoro del lenguaje.

Durante las visitas a clases y la realización de la exploración logopédica se pudo constatar que el 100 % planifican ejercicios para el componente sonoro del lenguaje, faltándole profundización en las actividades dirigidas a la voz, pronunciación y respiración según las necesidades del educando con rinolalia. Además es insuficiente la variabilidad y demostraciones por parte del logopeda de los ejercicios de este componente. Siendo evidente la necesidad de espacios para la realización de actividades metodológicas demostrativas sobre el tratamiento correctivo en el proceso de atención logopédica.

Como resultado de la exploración se pudio constatar que su aparato articulatorio, su labio superior, es corto, la movilidad lingual es disminuida, sus dientes son pequeños, la lengua es normal la úvula se reconstruyó y el paladar duro presenta una fisura palatina completa. La respiración de los educandos es clavicular evidenciándose una inspiración corta y superficial, la voz es débil, monótona y la pronunciación de los sonidos verbales bucales se altera al cambiar la zona de articulación por otras. Se afecta la pronunciación por los fonemas oclusivos y velares, cambian /p/ y /b/ por /m/; /t/ y /d/ por /n/; /k/ y /g/ se omiten.

Resultados generales del diagnóstico del estado actual de la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

<u>Aspectos positivos:</u>

-Disposición de los especialistas para elevar sus conocimientos sobre la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje a educandos con rinolalia.

-Adecuadas condiciones del local para la atención logopédica a educandos con rinolalia

Insuficiencias:

- Insuficiente actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.
- Poca creatividad en la concepción de variantes de medios de enseñanza para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje de manera integrada.
- Poco dominio de los pasos metodológicos en la realización de los ejercicios de rehabilitación de la respiración y la voz fundamentalmente.

-Carencia de actividades metodológicas que propicien la preparación de los logopedas en los aspectos relacionados con el componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

Epígrafe 2: Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

2.1: Fundamentos del proceso de atención logopédica.

La atención logopédica ha sido estudiada por diversos autores, entre los que se destacan Martín Pérez et al. (1980), Figueredo Escobar et al. (1984), Fernández Pérez de Alejo (2008a), Fernández Pérez de Alejo (2008b), Fernández Pérez de Alejo and García Veliz (2009), Fernández Pérez de Alejo and Rodríguez Fleitas (2012), Cobas Ochoa (2010), Cobas Ochoa and Gárciga Domínguez (2013), Chernousova (2008), Lores Leyva and Calzadilla González (2013), Arredondo Kassab et al. (2019); Calzadilla González (2021), entre otros.

El carácter de la atención logopédica en Cuba ha estado condicionado, de forma general por el desarrollo de la ciencia, y de forma particular por el progreso de la nación. En este sentido, en el documento rector de la República de Cuba, la Constitución, en el artículo treinta y nueve del capítulo V, dedicado a Educación y Cultura se establece que el estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias. Además en uno de los postulados de este documento se establece que la política educacional se fundamenta en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal, lo que confirma su carácter científico y desarrollador. Por tanto, la atención logopédica en el campo pedagógico está amparada por la política estatal.

La dirección del trabajo logopédico se institucionaliza en 1962, con la creación del departamento de enseñanza diferenciada y la extensión paulatina de una red de servicios con centro en la escuela. El marco legal de dicho proceso abarca la elaboración de orientaciones metodológicas, cartas circulares, resoluciones ministeriales, entre otros documentos normativos; entre ellos la Resolución Ministerial 47 de 1977, con la que se da inicio a la atención logopédica en las escuelas primarias y la Resolución Ministerial 92 de 2006, que regula la preparación logopédica de estudiantes seleccionados de las carreras de Licenciatura en Educación Primaria, Especial y Preescolar.

La labor logopédica en la escuela primaria se ha hecho más extensa y compleja con la atención a círculos infantiles y consejos populares, que concretan la competencia del logopeda en las siguientes direcciones:

- Prevención primaria de las dificultades y trastornos en la comunicación oral.
- Diagnóstico de las dificultades y trastornos en la comunicación oral.
- Prevención secundaria y terciaria, o sea dirigir el proceso de corrección y compensación de los trastornos en la comunicación oral.

Como parte del perfeccionamiento que se lleva a cabo en el sistema nacional de educación se instituyen las líneas fundamentales de desarrollo del trabajo logopédico en las escuelas, las que tienen como objetivo: lograr en los escolares una competitividad comunicativa, estratégica, como peldaño superior en la formación de habilidades lingüísticas. Para ello se diseñan las siguientes líneas (Fernández, G., García V. M., 2010):

- El perfeccionamiento del trabajo preventivo.
- La caracterización de las personas con trastornos de la comunicación y el lenguaje a partir del diagnóstico explicativo de sus necesidades y potencialidades. • La aplicación del enfoque–comunicativo de la lengua en el diagnóstico y la atención a los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
- El perfeccionamiento de las adaptaciones de acceso y curriculares fundamentales de la lengua materna.
- El proceso de tránsito de los alumnos provenientes de la escuela especial hacia la escuela de enseñanza general como parte del proyecto social de integración e inclusión de las personas con necesidades educativas especiales.
- La utilización eficiente de los recursos tecnológicos, en el desarrollo integral del lenguaje y las capacidades comunicativas.

En estas líneas se tienen en cuenta cuestiones importantes para el desarrollo de la atención logopédica, sin embargo, en ellas no se refleja la profundización en sus fundamentos teóricos, lo que se considera necesario.

La atención logopédica es definida por Morales (2004), como "un sistema de acciones o tareas basadas en el diagnóstico logopédico que tiene un carácter psicopedagógico y están dirigidas a la prevención, atención, evaluación e investigación científica de la comunicación humana y sus trastornos" (Morales, 2004, p. 24).

En esta misma línea, Fernández Pérez de Alejo y Rodríguez Fleitas (2012) la denominan como un "proceso especializado dirigido por el logopeda, de carácter integral, multi e interdisciplinario que se desarrolla preferentemente, en los diferentes contextos educativos, preescolares y escolares, la familia y la comunidad" (p. 46).

Por lo tanto está definición es integral ya que tiene al educando y a los agentes educativos como centro que intervienen en el proceso del currículo institucional del educando.

Estas definiciones plantean que la logopedia tiene como objetivo estimular, desarrollar las habilidades para el establecimiento de la comunicación, el lenguaje oral, escrito y/o facilitado en las diferentes situaciones de la vida y su contribución al desarrollo de la personalidad; suscitar necesidades de comunicación oral, escrita en diferentes contextos y estimular los procesos psicológicos que están en la base de los mecanismos expresivos, así como los procesos de compresión y producción de significados.

Este se inicia con el diagnóstico y utiliza como vía el método integral de atención logopédica, las ayudas, recursos y apoyos que propician la prevención, la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección y la compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación, el desarrollo multilateral del educando y la evaluación y seguimiento de los resultados. El componente sonoro del lenguaje comprende: la respiración, voz y pronunciación, siendo interés en esta investigación el diagnóstico del mismo en educandos con rinolalia.

El proceso de atención logopédica integral transita por 4 etapas fundamentales (Fernández Pérez de Alejo y Rodríguez Fleitas 2012):

1. Organizativa: Tiene duración de una quincena y coincide con el inicio de cada nuevo curso preescolar, se realiza entrevista con los miembros del consejo de dirección con el propósito de conocer las características esenciales de la escuela.

2. Exploración logopédica: En ella se inicia el trabajo, directamente con cada educando.

3. Tratamiento Logopédico: En ella, se hará una selección de los educandos con mayores dificultades, a los que se les impartirá un promedio de dos a tres frecuencias de tratamiento semanal. El orden de prioridad, la frecuencia del tratamiento los determinará el grado de superación general del lenguaje y las edades de los niños. Recibirán especial atención las edades tempranas y los grados terminales por su posible traslado a otro nivel de enseñanza.

4. Evaluación logopédica y seguimiento: se evalúa el cumplimiento del objetivo propuestos en la estrategia.

En estas etapas y su consecución, está implícita la habilidad de dirección, así como en la dirección de la clase o tratamientos logopédicos. Esta habilidad requiere de las siguientes acciones: organizar, planificar, ejecutar y controlar. Por tanto para dirigir la atención logopédica en las instituciones educacionales debe existir un dominio por parte del logopeda del contenido de cada una de ellas para la organización del trabajo en el aula logopédica. La concepción de la exploración logopédica ha de basarse en el modelo de diagnóstico dinámico o interactivo, al cual se aspira y por el que abogan diferentes autores (Cárdenas Toledo et al., 1979), Figueredo Escobar et al. (1984), Nieves Rivero (1987), Nieves Rivero (2002), Fernández Pérez de Alejo (2008a), Fernández Pérez de Alejo (2008b), Fernández Pérez de Alejo and Rodríguez Fleitas (2012).

Este modelo se centra en el análisis y explicación del desarrollo real y potencial, privilegia las funciones predictiva e interventiva del diagnóstico, lo cualitativo, la interacción entre lo interno y lo externo, presta especial atención al proceso y estilos de planificación, más que al propio resultado. En él se reconoce el valor de la zona de desarrollo próximo declarada por Vigotsky L., postula el determinismo social, y desde una concepción flexible, admite varias posibilidades por la propia variabilidad del desarrollo.

Estos fundamentos sustentan cómo se ha de proceder en la exploración logopédica, la que implica un estudio de las particularidades lingüísticas de los sujetos investigados para precisar la presencia de algunas alteraciones o trastornos del lenguaje propiamente dichos, en su relación con el desarrollo psíquico y de la personalidad en general. Dada su complejidad y el amplio campo que abarca, exige de una labor conjunta en la que participan numerosos especialistas (psicólogos, psiquiatras, neurólogos, otorrinolaringólogos y otros), además del logopeda, quien tiene la responsabilidad de emitir el diagnóstico del lenguaje. La labor médico-pedagógica es fundamental para el diagnóstico diferencial y explicativo del educando.

El proceso de evaluación, caracterización y diagnóstico logopédico implica la realización de un diagnóstico explicativo, donde se revele la relación causa-efecto, se caracterice de manera personalizada la forma en que se manifiesta el trastorno, a partir de la evaluación del proceso mediante técnicas de exploración que precisan el comportamiento del lenguaje expresivo y receptivo, de los sistemas funcionales sensoriales y de los sistemas de comunicación aumentativos en casos de trastornos más severos en la comunicación oral.

También se ha de precisar el nivel de la comunicación que se altera, su carácter primario o secundario, la causa a la que se asocia, cómo se altera la pronunciación, si es inteligible, poco inteligible e ininteligible; si se trata de una alteración fonética y/o fonológica, si es de carácter expresiva y/o receptiva, si necesita el empleo de objetos de referencia u otros mediadores para poder comunicarse, en fin que se comprenda cuál es su pronóstico para la elaboración de la estrategia de intervención logopédica. (Fernández Pérez de Alejo & Rodríguez Fleitas, 2012)

2.2. El componente sonoro del lenguaje, sus particularidades en los educandos con rinolalia.

El lenguaje corresponde a un sistema complejo conformado por tres componentes principales referidos a la forma, al contenido y al uso. La forma incluye la sintaxis, la morfología, y la fonología, el contenido abarca la semántica y el uso está comprendido en la pragmática. Asimismo Rondal (2000), señala la naturaleza multicomponencial del lenguaje, precisando que aunque se trata de un fenómeno homogéneo en su superficie, es un conjunto de distintos componentes integrados cuando su funcionamiento es normal.

El habla, como una manifestación sonora o acústica del lenguaje, se desarrolla a expensas de otros órganos y funciones anatómicas; es decir, como un sistema funcional sobreimpuesto o funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de los siguientes elementos:

- Una corriente de aire, la cual es producida por los pulmones y los músculos respiratorios.
- Un vibrador sonoro, constituido por las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe.
- Un resonador, conformado por la boca, la nariz y la garganta (o faringe).
- Articuladores, conformado por los labios, dientes, paladar duro, velo del paladar, mandíbula.

Estos cuatro elementos generan los sonidos del habla en el siguiente orden: en primer lugar, los pulmones suministran la columna de aire que, atravesando los bronquios y la tráquea, van a sonorizar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe.

Es en la laringe donde propiamente se produce la voz en su tono fundamental y sus armónicos; luego sufre una modificación en la caja de resonancia de la nariz, la boca y garganta (naso-buco-faríngea), en la que se amplifica y se forma el timbre de voz.

Los órganos articulatorios (labios, dientes, paladar duro, velo del paladar, mandíbula) van finalmente a moldear esa columna sonora, transformándola en sonidos y articulaciones del habla; es decir, en fonemas, sílabas y palabras.

Todos los elementos entran en funcionamiento cuando se habla, produciéndose cambios rápidos (0,10 y 0,05 segundos), exactos y regulares en el aparato del lenguaje verbal. Así, las cuerdas vocales se extienden y se relajan, cambian de forma los resonadores, se modifica la situación del velo del paladar, de la mandíbula inferior, de los labios, se eleva y desciende el diafragma, se mueve el tórax, todo esto en una forma sincronizada, automática y secuencial.

Ante la aparición de trastornos en los órganos articulatorios, se afecta su mecanismo de producción del lenguaje, según los trastornos de que se trate y con el ello el lenguaje y sus componentes. La importancia del lenguaje oral, como plataforma de todos los aprendizajes es una evidencia cada vez más compartida. Así Acosta (2008), indica que el lenguaje constituye un verdadero eje transversal de desarrollo que implica abordar su estimulación e intervención de forma conjunta por los especialistas de lenguaje, por otros profesionales, por los educadores y por el grupo familiar.

A través del desarrollo de la humanidad muchos individuos se han dedicado al estudio de los trastornos del lenguaje, unos con una óptica médica han abordado la solución de éstos mediante procedimientos de tipo clínico, otros con un enfoque pedagógico han fundamentado una vía de instrucción para la corrección o compensación de estas dificultades. Sin embargo, hay algo común en todos los que intervienen de una forma u otra en este trabajo, y el interés por mejorar la vida del hombre.

Como pedagogos valoramos en primer término la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con sus semejantes y en segundo lugar que la vía idónea de comunicación humana es indudablemente el lenguaje oral. El lenguaje oral puede verse limitado en su desarrollo debido a múltiples factores y uno de sus posibles trastornos es el que se conoce con la denominación de Rinolalia.

Por lo que cabe preguntarnos; ¿Influye la presencia de rinolalia en que el lenguaje cumpla sus funciones? Para dilucidar esta interrogante debemos analizar qué es la rinolalia y cómo se produce. La rinolalia es un trastorno del lenguaje oral caracterizado por la presencia de defectos en la pronunciación de los sonidos del lenguaje, lo que adquiere un matiz peculiar debido a la alteración de

la resonancia vocal, todo lo cual está relacionado con el trastorno de la participación normal de las cavidades bucal y nasal en la fonación y la articulación. En el proceso de emisión oral del lenguaje participan los aparatos articulatorio y resonador y el sistema respiratorio.

Las estructuras que integran estos niveles deben tener una participación coordinada para que tenga lugar un lenguaje oral correcto. En este sentido es importante resaltar que el sistema respiratorio aporta a este mecanismo la energía requerida en forma de columna de aire.

En el mecanismo de producción del lenguaje, durante el tiempo espiratorio se producirá la emisión sonora entrando en acción combinada los aparatos fonador y articulatorio. Es necesario señalar que la resonancia vocal presenta variaciones en dependencia del idioma que se hable, siendo de mayor o de menor grado sin que signifique ninguna alteración.

Si el aparato articulatorio se afecta a nivel de los resonadores, es decir, de tener lugar fisuras palatinas, velo corto, parálisis y paresis velares, desviaciones del tabique, obstrucciones de la cavidad nasal, entre otras variantes, puede ocurrir que se altere la resonancia de la voz y la precisión en la articulación de los fonemas del idioma, apareciendo una rinolalia.

Cualquiera de las causas mencionadas anteriormente y algunas otras pueden afectar orgánica o funcionalmente el aparato periférico del lenguaje, específicamente a nivel del analizador motor verbal, en este caso los procesos mentales que participan en la producción oral no se afectan, lo cual significa que tienen lugar la elaboración del programa motriz del enunciado, sin embargo, ocurre la alteración, a nivel periférico de la ejecución de dicho programa, lo cual se manifiesta en una alteración de la respiración, de la articulación de determinados fonemas y de la resonancia de la voz, manifestándose entonces como síntomas típicos, un trastorno respiratorio, trastorno de la pronunciación y del timbre nasal de la voz. Pudiéramos resumir planteando que se produce un trastorno del aspecto sonoro del lenguaje.

En relación con la severidad del trastorno mencionado podemos encontrar desviaciones de la norma en otros aspectos del desarrollo del lenguaje, como puede ser el desarrollo fonemático, lexical y gramatical. Estamos entonces en presencia de una comunicación imposible o al menos limitada en cuanto a su calidad y cantidad y en dependencia del grado de posibilidad de comunicación, estarán afectadas el resto de las funciones del lenguaje.

Vale reiterar que si este cuadro lo encontramos en un niño que está en etapa de desarrollo podemos deducir que sus posibilidades cognoscitivas van a verse restringidas y por lo tanto la deficiencia oral

va a tener repercusión en toda la vida de ese niño, estrechando el espectro de sus posibilidades de desarrollo.

La experiencia de la autora en la práctica educativa relacionada con la atención logopédica nos permite enfatizar en la necesidad de saber diferenciar cuando estamos en presencia de una rinolalia y en qué caso se considera el defecto una rinofonía, para lograr mayor claridad en el problema y el tratamiento a seguir en uno y otro caso. Se plantea de una manera bastante generalizada el criterio de considerar rinofonía cuando tiene lugar una alteración exclusiva del aspecto resonador, sin otros síntomas orales o vocales acompañantes.

Esto significa entonces que cuando existe un aumento patológico de la resonancia vocal, estaremos en presencia de una hiperrinofonía y en caso de disminución lo denominamos hiporinofonía. Siendo enfática, entonces consideramos que hiperrinolalia o hiporinolalia se produce cuando ese aumento o disminución de la resonancia vocal se manifiesta acompañado de alteraciones de los sonidos articulados.

La rinolalia como la mayoría de las alteraciones del desarrollo pueden aparecer en diferentes momentos de la evolución del individuo de esta manera podemos encontrar en su variante congénita y como una alteración adquirida. Por supuesto, será la rinolalia congénita mucho más significativa para el desarrollo en cuanto a influencias negativas, es decir que el individuo tendrá muchas más desviaciones de la norma oral al portar un trastorno congénito, que uno adquirido, debido a que el trastorno gravita sobre el individuo desde los momentos iniciales de su evolución entorpeciendo ésta.

Debemos mencionar entre las formas de trastorno un tipo especial de rinolalia que fue descrita por Weiss en 1935 y que se ha incluido dentro del grupo de las hiperrinolalias funcionales, nos referimos a la rinolalia espástica que fue denominada también hiperrinolalia activa. Se define con estos términos el trastorno, con carácter puramente funcional, que tiene lugar al producirse una contracción muscular de la parte superior de la faringe que al mismo tiempo tira del velo del paladar hacia abajo produciéndose además un levantamiento de la parte posterior de la lengua, la que provoca que el aire pase en exceso por el esfínter palatofaríngeo.

También se encuentra la variante mixta de la rinolalia cuando se combinan dos factores: una hiperrinolalia funcional que tiene por causa un mal funcionamiento del velo y una hiporinolalia orgánica que ocasiona un cierre relativo en la parte superior nasal.

Centrando nuestra atención en autores nacionales que han desarrollado investigaciones en el campo de la logopedia, contribuyendo con aportes valiosos en esta esfera específicamente en lo que respecta a la rinolalia y los trastornos de la voz, merita mencionar a:

Figueredo (1984) quien la conceptualiza etimológicamente, derivada del griego rhino, nariz y lalia, hablar, es un trastorno donde se afecta la pronunciación de los sonidos verbales, los que adquieren un matiz peculiar debido a una alteración resonancial, es decir se rompe el equilibrio, la participación normal de las cavidades bucal y nasal en la fonación y articulación. Puede estar aumentada o disminuída la función del resonador nasal, adquiriendo la voz el típico timbre nasal.

La rinolalia en dependencia de las causas que la origina pueden ser: Orgánicas y Funcionales.

Más adelante el referido autor refiere que se consideran orgánicas aquellas que están relacionadas con cambios estructurales de los órganos de la articulación y la fonación (velo del paladar, cavidad nasal y bucales insuficiente inervación velar) que provocan inadecuada distribución del flujo de aire en los resonadores y una incorrecta articulación de los sonidos del idioma; por ejemplo las fisuras palatinas, los procesos inflamatorios crónicos, entre otros.

Desde el punto de vista funcional, se consideran aquellas que son productos de un mal funcionamiento del velo del paladar o de la pared posterior de la faringe, en el proceso de emisión de los sonidos verbales, que provoca incorrecta realización del anillo velo-faríngeo y con ello, rompimiento del equilibrio entre los resonadores nasal y bucal. En estos casos no se detecta cambios anatómicos de los órganos que intervienen en los procesos de la articulación y fonación.

Por el tiempo de aparición del trastorno, la rinolalia se clasifica en: congénitas y adquiridas.

Rinolalia congénita: Se considera como tal, aquellos casos de rinolalia donde la base etiológica del surgimiento del trastorno se presenta en el momento del nacimiento por ejemplo, fisuras palatinas congénitas.

Rinolalia adquirida: Aquellos casos donde la base etiológica del trastorno aparece después del nacimiento ejemplo:(procesos inflamatorios de la cavidad nasal, tumores, fisuras palatinas adquiridas por traumas entre otras)

Por el mecanismo anatomofisiológico pueden ser abiertas y cerradas. En las rinolalias orgánicas abiertas se encuentra el velo del paladar corto que provocan surgimiento de la resonancia nasal y las fisuras palatinas y del velo (rompimiento del equilibrio entre los resonadores nasal y bucal.)

Las congénitas adquiridas pueden ser provocadas por causas exógenas y causas endógenas.

En la rinolalia abierta es típico el timbre nasal, la voz puede ser débil, monótona, poco modulada, como consecuencia de las alteraciones funcionales de la respiración (la inspiración es corta y superficial, insuficiente aire inspirado y pérdida de aire espirado por la nariz) y la incorrecta realización del anillo velo faríngeo.

La pronunciación de los sonidos verbales bucales se altera al cambiar las zonas de articulación por otras, por ejemplo, los intentos que realiza la persona con fisura de cerrar con la lengua la hendidura en el momento de la emisión de los sonidos.

En los casos más severos se afecta la pronunciación por los fonemas oclusivos y velares (insuficiente presión aérea intrabucal e hipofunción velar) son frecuentes los cambios de (p) y (b) por (m); (t) y (d) por (n), (k) y (g) se omiten. También se evidencian grandes dificultades en la pronunciación de los sonidos fricativos(s) y /f/, los que se omiten o se cambian por fonemas nasales. El fonema africado /ch/se cambia por /g/, /j/ y /t/ o se omite y el vibrante /r/ por lo general se omite.

La rinolalia cerrada se caracteriza por la disminución evidente de la función del resonador nasal como consecuencia de una obstrucción del paso libre del aire a la cavidad nasal en el proceso de emisión de los sonidos del idioma. En general, se reconoce por una causa orgánica, existe un obstáculo en la nariz o a la altura del velo del paladar.

En la rinolalia cerrada, el habla da la impresión auditiva de una persona que tiene catarro, puede ser orgánica (vegetaciones adenoideas) o funcional (levantamiento exagerado del velo como secuela de un catarro. En este caso, se altera la pronunciación de los sonidos nasales (m/, n/, ñ/), sustituyen por lo general por sonidos oclusivos y africados, los que son semejantes por el lugar de articulación, por ejemplo: /m/ por /p/; /n/por /d/; /ñ/ por /ll/, el timbre de la voz es hiponasal, voz apagada poco matizada y grata al oído. Se evidencia poca diferenciación entre la respiración nasal y bucal, predomina el tipo respiratorio clavicular que no es la más recomendable para el habla.

En relación con la severidad del trastorno, se pueden encontrar desviaciones de la norma de otros aspectos como pueden ser: el desarrollo fonológico, léxico-gramatical, teniendo en cuenta que entre los tres componentes del lenguaje existe una relación de dependencia, que los une en nexo fisiológico. Se está entonces en presencia de una comunicación verbal afectada en cuanto a su cantidad y calidad y en dependencia del grado de posibilidad de comunicación, estarán afectadas el resto de las funciones del lenguaje. Si este cuadro se encuentra en un niño que está en etapa de desarrollo, se puede deducir que sus posibilidades cognoscitivas se van a ver restringidas y por lo

tanto la deficiencia oral va a tener repercusión en toda la vida de ese niño estrechando sus posibilidades de desarrollo.

2.3: Fundamentos del proceso de atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

La práctica logopédica ha demostrado que los procedimientos propios de la Pedagogía son las vías idóneas para formar, desarrollar y educar el lenguaje, en correspondencia con las normas, además de corregir, compensar o prevenir sus distintas alteraciones.

El proceso de atención logopédica, como proceso pedagógico, debe combinar la enseñanza con la educación, la corrección de los trastornos del lenguaje con la formación en el educando de hábitos de conducta social, la eliminación de las deficiencias en el aprendizaje relacionados con los trastornos del lenguaje, con la formación integral de la personalidad. Por todo ello, el trabajo logopédico en la rinolalia se realiza sobre la base de los principios generales de la Pedagogía y deben en gran medida su mayor o menor éxito al grado de maestría del logopeda a la hora de aplicarlos en el proceso de tratamiento logopédico, pero además se emplean en el trabajo los principios específicos, metodológicos de la logopedia.

Cabe entonces preguntarnos, ¿Cómo se cumplen en el tratamiento logopédico los principios generales de la Pedagogía? En el tratamiento logopédico, se irá de los fonemas que el niño posee a los que no domina, graduando las dificultades, se ejercitará el vocabulario conocido para desarrollar la expresión oral y posteriormente utilizará palabras nuevas, en el trabajo con la respiración y la voz, se debe garantizar la introducción del tipo respiratorio correcto para después realizar la diferenciación de la respiración nasal y bucal y después trabajarle en función del habla, después de creada una base respiratoria adecuada se trabajará la normalización de la voz; aplicándose el principio de la asequilidad de la enseñanza.

El logopeda en su trabajo además, debe mantener la relación entre materias en la automatización de un fonema por ejemplo, no debe avanzar en la ejercitación del sonido, si el escolar no lo domina en sílabas, palabras y a su vez, debe iniciar el uso del fonema en oraciones con palabras que se han ejercitado y al final de la aplicación de las diferentes etapas debe hacerse un resumen o actividad generalizadora.

En el trabajo para la normalización de la voz debe trabajarse con una graduación sistemática la respiración, movilidad velar y cualidades de la voz, específicamente el timbre. La teoría del trabajo logopédico está constituida fundamentalmente por el sistema que orienta la adecuada instauración

de los fonemas y la práctica, además de los ejercicios funcionales de respiración y de voz que se realiza en el tratamiento logopédico.

Es necesario también aplicar en la práctica los conocimientos teóricos, a través de diversas actividades. Es importante que el logopeda despierte el interés del escolar por el tratamiento, motivándolo adecuadamente. Debe ilustrar y objetivar la terapia a aplicar, así como saber dirigir la atención hacia los aspectos que le interesen, para lograr esto es muy importante la personalidad del logopeda, su conducta, ya que el niño por sí solo no puede librarse de las preocupaciones interiores que perturban su actividad y comportamiento, es la psicoterapia lo que permite relacionarse racionalmente con la realidad, reduciendo su subjetividad y dificultades en la conducta.

En el trabajo logopédico es importante tener presente, que toda imagen de la realidad tiene su punto de partida, en la percepción de los objetos por medio de los analizadores. En la misma observación, comienza un proceso intelectual: análisis, síntesis, abstracción y generalización; por lo que el logopeda debe hacer uso de láminas, vocabulario ilustrado, juguetes, etc., así como valerse de todas las posibilidades de percepción posible para facilitar la adecuada articulación de los diferentes fonemas.

La experiencia de la autora en el trabajo con escolares rinolálicos, es del criterio que es importante además, cuando se trabaja la respiración vinculada a la normalización de la voz, utilizando el analizador táctil, realizar el control de la respiración costal- diafragmática colocando la mano del niño en el abdomen del logopeda y en el suyo, también hacer notar la salida del aire en sonidos nasales y orales. Para evitar el olvido, el logopeda debe saber destacar lo principal de la terapia que está aplicando, relacionar la nueva etapa de tratamiento con las habilidades que ya posee el escolar, así como posibilitar la aplicación de los conocimientos que se trasmiten a la actividad práctica.

De igual forma es necesario vincular la terapia del habla con la educación, con el fin de contribuir al desarrollo integral del niño con deficiencias en el lenguaje. Vinculado a todo este trabajo de reeducación pedagógica, para el óptimo cumplimiento de los objetivos correctivo-instructivo-educativo, es necesario que se cumplan por el logopeda además los principios de la logopedia.

Para cumplir con dichos principios hay que partir de que el tratamiento logopédico no establece para la rinolalia, sino para niños rinolálicos teniendo en cuenta la personalidad de este y después de hacer una investigación minuciosa se diagnostica y clasifica el trastorno pero el trabajo se planifica sobre la base de la manifestación de la sintomatología concreta en el caso y sus particularidades individuales, teniendo en cuenta las leyes generales del desarrollo normal tanto verbal como psíquico. Al trabajar

con los aspectos del componente sonoro del lenguaje con el rinolálico se debe aprovechar la mayor cantidad de aferencias posibles para superar las deficiencias del analizador verbomotriz, en el sector periférico, es por ello que se utiliza ampliamente los analizadores: visual, auditivo y táctil.

Consideramos importante insistir que el tratamiento logopédico en caso de rinolalia no se dirija a aspectos aislados, sino al desarrollo del lenguaje como un todo teniendo en cuenta la sintomatología principal sin descuidar otras características psicopedagógicas que pueden estar presentes complicando el cuadro del trastorno. Por ejemplo frecuentemente en los casos de rinolalia orgánica abierta, por fisuras palatinas congénitas la alteración de articulación respiración y de voz (hipernasalidad) se acompaña de un insuficiente desarrollo de los componentes léxico-gramatical y de los procesos fonemáticos, unido a dificultades en el desarrollo físico y psíquico del niño; es por ello que para obtener éxitos en esta labor hay que trabajar simultáneamente todos los aspectos para ello se tendrá en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentra el lenguaje para la selección de los métodos, procedimientos y material que se utilizará en el tratamiento.

Toda limitación del lenguaje afecta la comunicación y puede conducir a que el sujeto asuma diversas conductas negativas, por lo que el logopeda debe hacer uso de la psicoterapia como instrumento valioso para influir sobre el niño y la familia, empleando para ello diversas formas de psicoterapia.

El contenido y la forma del lenguaje del niño se desarrollan, mediante la influencia activa del medio, de la familia, de la escuela, de la comunidad que educa su lenguaje. Esta influencia puede ser a veces contradictoria; por una parte estimula al niño para la superación de sus insuficiencias (deseos de no quedarse atrás con respecto a sus compañeros, evitar burlas, etc) y por otra, puede reforzar estas insuficiencias (autolimitación de la utilización del lenguaje por el temor a las burlas).

Por eso es necesario coordinar las clases logopédicas con el trabajo de la familia y de la escuela, instituciones que estimulan en el niño la necesidad de mejorar el lenguaje, que lo ayudan en esta tarea y que le proporcionan el modelo 6 vivo del lenguaje correcto y que organiza en la actividad correspondiente, sin lo cual se dificulta el éxito del trabajo logopédico y a veces es imposible.

En el tratamiento al escolar rinolálico es recomendable la influencia psicoterapéutica desde antes de la operación fundamentalmente para la familia, para garantizar la confianza e incorporación en la labor logopédica. Después de la intervención quirúrgica se continuará el trabajo psicoterapéutico a lo largo de todo el tratamiento, desde la preparación psicológica hasta motivar y garantizar la incorporación del niño al trabajo y se deberá mantener con hilo conductor, premiando éxitos o exhortando al niño a

que se esfuerce y lo realice mejor apoyándonos en actividades lúdicas, rítmicas, cuentos, trabajo manual, cuando el niño es pequeño.

El trabajo logopédico no sería integral, ni eficaz, si el logopeda no orienta a los maestros, auxiliares pedagógicas, padres y a cuantos tengan participación en la educación de los niños que presentan esta logopatìa, en relación con los procedimientos a seguir para influir de forma positiva sobre la corrección y desarrollo del leguaje y de sus particularidades psicológicas, continuándose así la iniciada en el aula logopédica.

Un lugar especial dentro del trabajo logopédico lo ocupa la labor profiláctica y el desarrollo de un trabajo activo y sistemático a favor del uso correcto de la lengua materna y el desarrollo de todos los componentes del lenguaje. En toda esta labor tan ardua se evidencia la aplicación consecuente de los principios pedagógicos y el éxito dependerá de la mayor y mejor utilización de los mismos por el logopeda, quedando reafirmado así el carácter pedagógico de la logopedia.

Existe criterios discrepantes en relación con el momento más adecuado de realizar las operaciones de los niños rinolálicos, sin embargo, no es este el último punto de desacuerdo en la rinolalia, también hay diferencias en cuanto a si es o no necesario dar tratamiento correctivo al niño antes de ser operado, en aquellos casos en que la operación no puede hacerse en etapas tempranas del desarrollo, a criterio de la autora todo está en dependencia con el estado de salud de este y como a criterio de los especialistas y en concordancia con la familia pueda o no la operación.

La atención logopédica en caso de educandos con rinolalia parte de un diagnóstico, el mismo está direccionado al análisis que se realiza para determinar cuál es la situación que presenta el componente sonoro del lenguaje para definir la conducta a seguir. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, en la exploración del lenguaje y la historia de salud del menor que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando y cuándo se debe intervenir. Lo que si debe quedar que en todo momento la familia debe ser claramente orientada, en primer lugar sobre la patología que tiene en menor, su cuadro sintomatológico, la repercusión de esta en el estado de salud físico y psicológico del menor y las posibilidades correctivas/ compensatoria que tiene desde su estado de salud y su lenguaje.

El estudio clínico, psicopedagógico, logopédico y del entorno del sujeto propicia el carácter integral del diagnóstico, en particular del componente sonoro del lenguaje. Para arribar al diagnóstico se realiza la exploración logopédica y “se establecen los indicadores y criterios de evaluación o

parámetros para su evaluación con un carácter explicativo y descriptivo lo cual favorece la determinación del tratamiento a seguir". (Nieves Rivero, 2002, p. 15)

El diagnóstico logopédico es el resultado de un proceso de investigación, de integración de los resultados donde se tiene en cuenta las ayudas prestadas al niño y su asimilación, el desempeño en las actividades, el proceso y resultado de las tareas realizadas, las potencialidades de su desarrollo y de la corrección y o compensación de los trastornos de la comunicación y el lenguaje; este debe ser explicativo y personalizado, que revele las particularidades y dinámica del desarrollo del sujeto que se estudia. Se debe declarar las necesidades y potencialidades del niño y su entorno educativo.

En la evaluación del estado del componente fonético de los educandos con rinolalia, el logopeda ha de precisar aspectos puntuales como: la posición articulatoria del sonido que se altera en la sílaba (inicial, medio, final, directa, inversa o directa doble) si el error es constante o inconstante si los sonidos pertenecen a un mismo grupo fónico, el examen físico del aparato articulatorio (observar la estructura y funcionamiento de los órganos: cavidad nasal, velo del paladar), en correspondencia con el tipo de rinolalia.

El diagnóstico del componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos según los documentos normativos tiene dos fines.

- Revelar la participación del sistema resonador en uno u otros fonemas.
- Precisar la alteración que se produce en la articulación de los fonemas, en función de la caracterización del estado de la pronunciación.

En el primer caso, hay que controlar la salida del aire y las características de la emisión del sonido con el oído y con la vista, colocando un espejo debajo de las fosas nasales. Para ello se ha de seleccionar correctamente el material verbal y las técnicas que permitan diferenciar el aumento o disminución de la función del resonador nasal. Se ha de caracterizar la voz, con todas sus cualidades, por ejemplo, si el tono es agudo, medio, grave si el timbre es nasal, sonoro, ronco, sordo y la intensidad si es normal, débil o fuerte. El segundo coincide con la investigación de la pronunciación.

De ahí la necesidad nuevas actividades y ejercicios que fortalezcan el componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

Las dificultades articulatorias que se presentan los educandos con rinolalia y en las que debemos centrar nuestra atención logopédica son:

- Sustitución: ante la dificultad de articular u sonido determinado, el educando le sustituye por otro más asequible.

- Omisión: consiste en la omisión del fonema o sílaba que el sujeto no sabe pronunciar. En el caso de la rinolalia abierta omiten los sonidos fricativos: /s/ y /f/.
- Inserción o adición: consiste en introducir o articular una palabra, un sonido vocálico insistente en dicha palabra, que le sirve de muletilla para intentar salvar la dificultad que representa su producción.
- Distorsión: puede definirse los sonidos distorsionado, aproximado y definidos, como aquellos que no derivan de una sustitución definida, y cuya incorreción se debe, por el contrario a una mutilación, falta de claridad o un descuido que origina un sonido completo.

El tratamiento logopédico dada la complejidad de la patología debe ser preventivo y correctivo-compensatorio. En este proceso correctivo intervienen un equipo multidisciplinario de especialistas, quienes en diferentes etapas realizan las diferentes intervenciones según corresponda en cada caso. No siempre es posible operar en edades tempranas, justificándose la intervención del logopeda con carácter profiláctico. La atención logopédica se divide en dos etapas: preoperatoria y posoperatoria, existiendo diferentes criterios antes y después de operar; en aquellos casos que la operación no puede hacerse en etapas tempranas del desarrollo.

La mayoría de los especialistas del perfil médico defienden la idea de que la actuación funcional logofoniátrica debe comenzar siempre posterior a la operación. También, existe el criterio opuesto de la efectividad del tratamiento preoperatorio y se destaca el valor del trabajo interdisciplinario de especialistas como protesistas, ortodoncistas, estomatólogos, psicólogos, otorrinos y logofoniatras en cualquier caso y principalmente, cuando se presenta una fisura palatina.

El objetivo de la atención logopédica es contribuir a un buen desarrollo físico del niño como base para la prevención de la insuficiencia general en el desarrollo del lenguaje y de dificultades en el aprendizaje que pudieran acontecer.

En el tratamiento logopédico, se irá de los fonemas que el niño posee a los que no domina, graduando las dificultades, se ejercitará el vocabulario conocido para desarrollar la expresión oral y posteriormente utilizará palabras nuevas, en el trabajo con la respiración y la voz, se debe garantizar la introducción del tipo respiratorio correcto para después realizar la diferenciación de la respiración nasal y bucal y después trabajarle en función del habla, después de creada una base respiratoria adecuada se trabajará la normalización de la voz; aplicándose el principio de la asequibilidad de la enseñanza.

Pero además el logopeda en su trabajo debe mantener la relación entre materias en la automatización de un fonema por ejemplo, no debe avanzar en la ejercitación del sonido, si el escolar no lo domina en sílabas, palabras y a su vez, debe iniciar el uso del fonema en oraciones con palabras que se han ejercitado y al final de la aplicación de las diferentes etapas debe hacerse un resumen o actividad generalizadora.

En el trabajo para la normalización de la voz debe trabajarse con una graduación sistemática la respiración, movilidad velar y cualidades de la voz, específicamente el timbre. La teoría del trabajo logopédico está constituida fundamentalmente por el sistema que orienta la adecuada instauración de los fonemas y la práctica, además de los ejercicios funcionales de respiración y de voz que se realiza en el tratamiento logopédico.

Es necesario también aplicar en la práctica los conocimientos teóricos, a través de diversas actividades. Es importante que el logopeda despierte el interés del escolar por el tratamiento, motivándolo adecuadamente. Debe ilustrar y objetivar el tratamiento a aplicar, así como saber dirigir la atención a los escolares hacia los aspectos que le interesen, para lograr esto es muy importante la personalidad del logopeda, su conducta, ya que el niño por sí solo no puede librarse de las preocupaciones interiores que perturban su actividad y comportamiento, es la psicoterapia lo que permite relacionarse racionalmente con la realidad, reduciendo su subjetividad y dificultades en la conducta.

En el trabajo logopédico es importante tener presente, que toda imagen de la realidad tiene su punto de partida, en la percepción de los objetos por medio de los analizadores. En la misma observación, comienza un proceso intelectual: análisis, síntesis, abstracción y generalización; por lo que el logopeda debe hacer uso de láminas, vocabulario ilustrado, juguetes, etc, así como valerse de todas las posibilidades de percepción posible para facilitar la adecuada articulación de los diferentes fonemas. Por ejemplo en el trabajo con esta patología es importante además, cuando se trabaja la respiración vinculada a la normalización de la voz, utilizando el analizador táctil, realizar el control de la respiración costal- diafragmática colocando la mano del niño en el abdomen del logopeda y en el suyo, también hacer notar la salida del aire en sonidos nasales y orales.

Para evitar el olvido, el logopeda debe saber destacar lo principal de la terapia que está aplicando, relacionar la nueva etapa de tratamiento con las habilidades que ya posee el alumno, así como posibilitar la aplicación de los conocimientos que se trasmiten a la actividad práctica. De igual forma

es necesario vincular la terapia del habla con la educación, con el fin de contribuir al desarrollo integral del niño con deficiencias en el lenguaje.

Vinculado a todo este trabajo de reeducación pedagógica, para el óptimo cumplimiento de los objetivos correctivo-compensatorio, es necesario que se cumpla por el logopeda además los principios de la logopedia. Para cumplir con dichos principios hay que partir de que el tratamiento logopédico no establece para la rinolalia, sino para niños rinolálicos teniendo en cuenta la personalidad de estos y después de hacer una investigación minuciosa se diagnostica y clasifica el trastorno pero el trabajo se planifica sobre la base de la manifestación de la sintomatología concreta en el caso y sus particularidades individuales, teniendo en cuenta las leyes generales del desarrollo normal tanto verbal como psíquico.

Al trabajar con los aspectos del componente sonoro del lenguaje con el rinolálico se debe aprovechar la mayor cantidad de aferencias posibles para superar las deficiencias del analizador verbomotriz, en el sector periférico, es por ello que se utiliza ampliamente los analizadores: visual, auditivo y táctil. Es importante que el tratamiento logopédico en la rinolalia no se dirija a aspectos aislados, sino al desarrollo del lenguaje como un todo teniendo en cuenta la sintomatología principal sin descuidar otras características psicopedagógicas que pueden estar presentes complicando el cuadro del trastorno.

Por ejemplo frecuentemente en los casos de rinolalia orgánica abierta, por fisuras palatinas congénitas la alteración de articulación respiración y de voz (hipernasalidad) se acompaña de un insuficiente desarrollo de los componentes léxico-gramatical y de los procesos fonemáticos, unido a dificultades en el desarrollo físico y psíquico del niño; es por ello que para obtener éxitos en esta labor hay que trabajar simultáneamente todos los aspectos para ello se tendrá en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentra el lenguaje para la selección de los métodos, procedimientos y material que se utilizará en el tratamiento.

Toda limitación del lenguaje afecta la comunicación y puede conducir a que el sujeto asuma diversas conductas negativas, por lo que el logopeda debe hacer uso de la psicoterapia como instrumento valioso para influir sobre el niño y la familia, empleando para ello diversas formas de psicoterapia.

El contenido y la forma del lenguaje del niño se desarrollan, mediante la influencia activa del medio, de la familia, de la escuela, de la comunidad que educa su lenguaje. Esta influencia puede ser a veces contradictoria; por una parte estimula al niño para la superación de sus insuficiencias (deseos de no quedarse atrás con respecto a sus compañeros, evitar burlas, etc) y por otra, puede reforzar estas

insuficiencias (autolimitación de la utilización del lenguaje por el temor a las burlas). Por eso es necesario coordinar las clases logopédicas con el trabajo de la familia y de la escuela, instituciones que estimulan en el niño la necesidad de mejorar el lenguaje, que lo ayudan en esta tarea y que le proporcionan el modelo vivo del lenguaje correcto y que organiza en la actividad correspondiente, sin lo cual se dificulta el éxito del trabajo logopédico y a veces es imposible.

El trabajo logopédico no sería integral, ni eficaz, si el logopeda no orienta a los maestros, auxiliares pedagógicas, padres y a cuantos tengan participación en la educación de los niños que presentan esta logopatìa, en relación con los procedimientos a seguir para influir de forma positiva sobre la corrección y desarrollo del leguaje y de sus particularidades psicológicas, continuándose así la iniciada en el aula logopédica.

Un lugar especial dentro del trabajo logopédico lo ocupa la labor profiláctica y el desarrollo de un trabajo activo y sistemático a favor del uso correcto de la lengua materna y el desarrollo de todos los componentes del lenguaje. En toda esta labor tan ardua se evidencia la aplicación consecuente de los principios pedagógicos y el éxito dependerá de la mayor y mejor utilización de los mismos por el logopeda, quedando reafirmado así el carácter pedagógico de la logopedia.

Epígrafe 3: Folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

Los resultados de la práctica y del diagnóstico inicial, ha permitido reconocer la pertinencia de elaborar un folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje, dirigido a los maestros logopedas para los educandos con rinolalia como vía para dar solución al problema de la investigación.

3.1 Fundamentación del folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

Con el afán de contribuir a la preparación y participación protagónica de los docentes logopedas, se propone un folleto para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia, contentiva de actividades con recursos cognitivos e instrumentales que les permiten dinamizar la atención logopédica.

Estos les permitirán una mejor preparación para el diagnóstico y atención del componente sonoro del lenguaje y fortalecerá el vínculo en educandos con rinolalia.

Objetivo general: Desarrollar el componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia a través de actividades variadas e integradas.

El folleto de actividades será implementado por los docentes logopedas, en las diferentes sesiones del tratamiento y contribuirá a garantizar una adecuada activación del componente sonoro del lenguaje en estos educandos. Además el contenido de este folleto será utilizado en la autopreparación y en las actividades de preparaciones metodológicas de los especialistas.

Estas actividades van estar dirigidas al trabajo correctivo –compensatorio, y profundizar en el proceso de diagnóstico y evaluación.

Es importante en este proceso de atención logopédica a escolares con rinolalia dedicarle un espacio a la etapa preoperatoria, concebir actividades a realizar tanto en la escuela como en el hogar, contribuirá en la segunda etapa del tratamiento a un trabajo mucho más exitoso en la rehabilitación de estos casos.

Ahora bien, ¿En qué dirección deberá dirigirse la atención terapéutica preoperatoria?

Comenzaremos por plantear que el trabajo preoperatorio debe estar dirigido a posibilitar un buen desarrollo físico del niño y evitar la aparición de la insuficiencia general del desarrollo del lenguaje y el retardo psíquico, debe organizarse teniendo en cuenta la edad del niño e incluirá:

- Estimulación de la comunicación.
- Concentración visual y auditiva.
- Desarrollo de la motricidad.

¿Qué actividades se pueden realzar?

Para logra esto recomendamos actividades tales como:

- Conversar con el niño frecuentemente, en forma suave y cariñosa, sonreírle, acariciarle.
- Jugar con el niño apareciéndose y ocultándose de su campo visual, hablándole todo el tiempo. - Reforzar sus emisiones sonoras repitiéndolas con ellos tanto en situaciones positivas como negativas.
- Una vez que el niño comprende el lenguaje podemos incluir actividades con todo tipo de juguetes donde la sonoridad está a cargo del adulto que dirige el juego y el fin el lograr que el niño realice determinadas acciones orientadas y las acompañe con manifestaciones orales. Ej. Seleccionamos un gato de juguete y le decimos al niño, este es el gato y dice miau el niño debe tratar de repetir miau, miau. El gato se fue a la calle sin permiso de su mamá y se dió un golpe, como le duele la patica al gato, ¡ay, ay!, el niño repetirá ¡ay, ay! Pueden realizarse diferentes juegos que estimulen en el niño el lenguaje, y este combinarlo con ejercicios respiratorios.

En la realización de todo este trabajo es necesario tener en cuenta que al presentar un objeto desconocido al niño, debe utilizarse la cantidad máxima posible de analizadores. El niño debe oír su

denominación, observarlo, tocarlo, oír su sonido, actuar con él. Puede incluirse reconocimiento de objetos por su sonoridad, por su forma, por la denominación.

Se trabaja en la ejecución de oraciones por orden. En esta etapa preoperatoria podemos trabajar además las generalizaciones y la gimnasia articulatoria pasiva y activa con elementos aislados según las posibilidades individuales. Todo este trabajo no puede estar separado de la acción psicoterapéutica que de forma permanente es necesario ejercer tanto sobre el propio rinolálico, como sobre la familia Esto requiere de la explicación de la secuela del trastorno y una valoración objetiva de las posibilidades anatomofuncionales de restablecimiento. Es preciso insistir en la importancia del trabajo funcional sistemático.

3.2: Presentación de la estructura y contenido.

Se proponen actividades que contribuirán a la corrección del componente sonoro del lenguaje, todas tienen las siguientes características:

- Título.
- Objetivo.
- Materiales
- Método
- Responsable.
- Forma de ejecución.
- Evaluación

3.3 Folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.



Actividad: # 1 

Título: El espejo nublado.

Objetivo: determinar la capacidad del aire espirado por el educando.

Responsable: logopeda

Materiales: espejo, láminas

Método: demostrativo

Forma de ejecución: el logopeda se pondrá de frente al educando para realizar la actividad. Para determinar la capacidad del aire espirado por el educando es necesario tener en cuenta parámetros.

-Grado de permeabilidad y funcionalidad nasal: se comprueba mediante un pequeño espejo colocado horizontalmente debajo de la nariz del educando.

- Determinación del tipo de respiración: La forma de respirar espontánea del educando puedes ser observada en la primera vista. Se debe observar si los músculos del cuello participan en este acto, que zona del tronco se mueve con mayor amplitud al respirar y cómo coordina el aire con la emisión vocal (coordinación fono-respiratoria). Así se sabrá qué tipo de respiración utiliza el educando.

Se observará si el espejo queda empañado simétricamente por el aire que sale de unos de los orificios de la nariz y del otro, o si por el contrario uno empaña el espejo más que el otro.

-Participación de la musculatura del cuello durante la respiración: colocado el educando de espalda al logopeda, esté colocará las manos con los dedos pulgares sobre la columna del mismo y el resto de los dedos hacia afuera. Primeramente se efectúa a la altura de la primera o segunda vertebra dorsal, mientras respira normalmente, luego se van desplazando las manos hasta la zona de la cintura observando en cada lugar y a lo largo del tórax.

Se insistirá en la repetición del ejercicio hasta lograr su correcta realización de forma voluntaria.

Evaluación: Se evaluará si utiliza correctamente la respiración costo diafragmática.



Actividad: # 2

Título: Respira correctamente.

Objetivo: comprobar la funcionalidad de las fosas nasales y estimular la respiración correcta.

Materiales: espejo

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda invita al educando a realizar 20 respiraciones normales, primeramente tapándose un orificio de la nariz con ayuda del dedo pulgar, teniendo cuidado de no comprimir el orificio con el tabique al tapar el orifico derecho de la nariz con el dedo pulgar oprimiendo suavemente hacia arriba. Luego se repite la actividad por el orificio del lado izquierdo de la nariz haciendo otras 20 respiraciones y con el dedo pulgar oprimiendo suavemente hacia arriba, siempre con la boca cerrada. De esta forma puede verse si el educando respira igualmente por ambos orificios, o si presenta alguna anomalía en la nariz, o pólipos nasales y si por el contrario respira con mayor dificultad por uno de los orificios nasales.

Se le corrige las dificultades que presentó en la realización del ejercicio, demostrándosele la forma correcta de respirar.

Evaluación: Se le invita al niño a realzar ejercicios respiratorios y corregimos sistemáticamente su realización.

Actividad: # 3 

Título: La cuenta numérica.

Objetivo: caracterizar el tipo de respiración en educando con rinolalia.

Materiales: láminas, espejo

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda invita a expirar al educando y pedirle que inicie una cuenta numérica del 1-20 en voz alta. Luego le comunica que una vez acabado el aire respire rápidamente

para proseguir la cuenta numérica. En esta actividad se explora detenidamente la forma de respiración (costo-diafragmática, clavicular o abdominal).

Es el momento de demostrar al educando la forma correcta de respiración y se le invita a repetir varias veces el ejercicio.

Evaluación: Se invita al niño a demostrar la forma correcta de realización de los ejercicios y se le corrige en cada caso las posiciones incorrectas.

Actividad: # 4

Título: Ejercicios respiratorios acompañados de movimientos de brazos.

Objetivo: Ampliar la capacidad respiratoria en los niños rinolálicos.

Materiales: Se utiliza el propio cuerpo del niño.

Métodos: Demostrativo

Forma de ejecución:

El niño se coloca las manos en la cintura, elevándose sobre la punta de los pies durante la inspiración, volviendo a la posición normal, mientras dura la espiración.

Se combinarán levantando los brazos por los costados a la altura de los hombros, a la vez que se eleva sobre la punta de los pies durante la inspiración volviendo a la posición normal en la espiración. De igual forma desde la posición de sentado se le indica al niño como realizar la inspiración y espiración, y como debe controlar con sus manos su realización correcta.





Evaluación: Se le pide al niño realizar el ejercicio varias veces como forma de valorar su comprensión para posterior realización en el hogar.

Actividad: # 5

Título: Ejercicios respiratorios con materiales.

Objetivo: Ampliar la capacidad respiratoria en los niños.

Materiales: En el trabajo preventivo correctivo con los escolares rinolálicos se deben utilizar materiales muy simples para que su manejo no los retraiga y que vean estos medios como objetos de juegos para de esta forma poder motivar su actividad.

Será un material al alcance de cualquier logopeda e incluso para el maestro en el aula y que esté dirigido principalmente a la realización de ejercicios de soplo, actuando de esta forma sobre la función respiratoria, su dominio y disciplina.

Forma de ejecución

Ejercicios de soplos:

Primero el logopeda soplará sobre la mano del niño, para que él sienta la fuerza del aire que sale. Después se hará que sea él mismo el que sople sobre su propia mano, para que perciba la misma sensación que antes.

Este ejercicio se puede repetir en distintas intensidades. Primero se le indicará "sopla flojo" o "sopla fuerte". Después se soplará sobre su propia mano con una u otra intensidad para que el niño aprenda a discriminarlos y a continuación lo repite con la misma fuerza, sin más indicación que pedirle que sople y así vea como la fuerza de emisión del aire levanta el papel. Desde una distancia de 10 cm. aproximadamente, se le irá alejando paulatinamente para que tenga que ir aumentando la fuerza de soplo a medida que se le aleja el papel para que éste no deje de moverse.

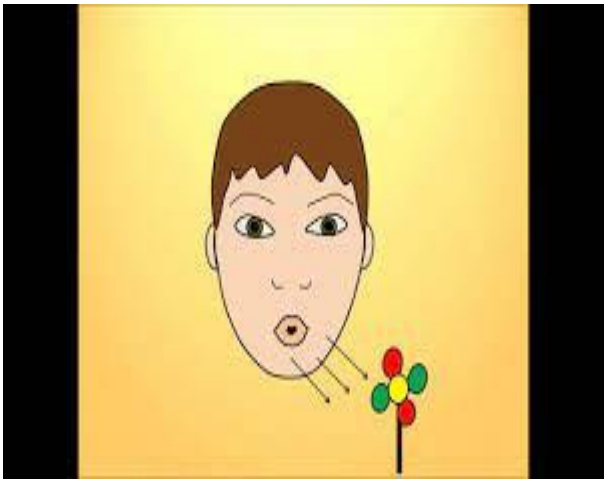


Sobre una mesa de esparce en un pequeño radio, pedacitos de papel que el niño tiene que hacer volar de un solo soplo, se adaptará a la capacidad del niño, poniendo más o menos papelitos sobre la mesa.

En lugar de pedacitos de papel también se pueden utilizar moticas de algodón o pequeñas plumas con el fin de que sean ligeras y que vuelen fácilmente.

Algunos de estos ejercicios pueden ser utilizados por el maestro en las clases de música, clases de presentación de fonemas o en actividades de continuidad, en forma individual o grupal.





Evaluación: Se evalúa sistemáticamente en los diferentes momentos de las actividades que realice el escolar, es decir en el gabinete, el aula, en las clases de Educación Física y Educación Musical.

Actividad: # 6 

Título: Dónde me encontrarás. Ver Anexo 4.

Objetivo: Determinar el nivel de articulación afectado y estimularlo.

Materiales: lámina, tarjetas

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda le presentará al educando las tarjetas para trabajar determinados aspectos de la fonética y va tomando notas de los sonidos que cambia, distorsionan u omiten haciendo siempre precisión en los sonidos nasales, (m, n, ñ), oclusiva y africado, los que son semejantes por el lugar de articulación, por ejemplo: /m/ por /p/; /n/ por /d/; /ñ/ por /ll/.

Evaluación: Se invita al niño a repetir palabras en diferentes tarjetas con los sonidos en diferentes posiciones.

Actividad: # 7 

Título: Cuidemos nuestra voz.

Objetivo: comprobar las cualidades de la voz a través de la lectura.

Materiales: espejo

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: se invita al educando a una lectura en voz alta, donde el logopeda debe evaluar los aspectos relacionados.

-La articulación y los rasgos prosódicos. (Ver anexo 5)

El logopeda debe insistir que los sonidos vocálicos, los consonánticos, se oigan con nitidez. Luego precisará en la articulación de los sonidos nasales, oclusivos, fricativos y velares, en este aspecto se recoge si el educando omite, distorsiona, añade o sustituye unos de estos sonidos.

Evaluación: Se invita al niño a pronuncias diferentes sonidos en palabras y frases y su lenguaje contextual.

Actividad: # 8

Título: Ejercicios buco - faciales.

Para facilitar una correcta articulación es preciso ejercitar y agilizar previamente los órganos que intervienen en la misma, pues aunque no exista defecto orgánico, muchas veces la articulación imperfecta es debida a la falta de desarrollo y habilidad motriz general que afecta a los órganos buco - faciales.

Objetivo: Ejercitar los órganos articulatorios que intervienen en al acto verbal.

Materiales: Ejercicios con la participación de los labios, lengua

Métodos: Demostrativo

Responsable: Logopeda

Forma de realización:

Ejercicios para la lengua**.**

Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en movimientos repetidos a distintos ritmos, según indique el maestro.

Sacar la lengua lo mínimo posible, sin abrir completamente la boca, de forma que sólo aparezca la punta entre los labios.

Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre los labios superiores.

Dirigir la lengua a los lados de la boca apoyando la punta en la cara interna de la mejilla, sucesivamente (el maestro orientará a los niños que pongan la lengua como si tuvieran un caramelo en uno u otro lado de la boca)



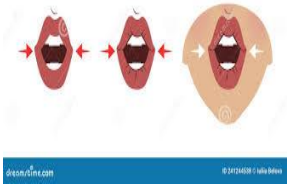
Ejercicios para los labios.

Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca.

Sonreír sin abrir la boca y a continuación reír.

Morderse el labio inferior con los dientes superiores y a la inversa.

Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios.





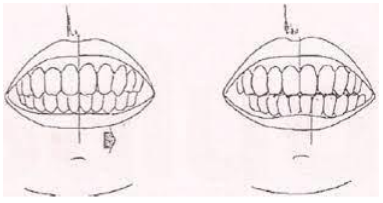
Ejercicios para el maxilar.

Abrir la boca con un ritmo lento y cerrarla a un ritmo rápido y viceversa siempre realizar el ejercicio con distintos ritmos.



Ejercicio de mascar o realizar los movimientos similares.

Apretar los dientes y lentamente aflojarlos.



Evaluación: Pedirle al niño la realización de cada ejercicio de forma independiente y el logopeda corregirá en caso necesario

Actividad: # 9

Título: Escúchame atentamente.

Objetivo: evaluar la percepción auditiva (estado del oído fonemático). Anexo 6

Materiales: pantalla perforada

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: esta actividad el logopeda debe tener en cuenta, tres momentos: discriminación auditiva (sin mirar al logopeda), discriminación fonética (mirando al logopeda) y discriminación fonética en tarjetas. El logopeda va a determinar si omiten, distorsionan, añade o sustituye unos de estos sonidos representados en las tarjetas y que nivel de articulación pertenece y va a ir realizando anotaciones en la hoja de exploración.

Evaluación: Pronunciar palabras para que el niño discrimine los sonidos de forma correcta.

Actividad # 10. Pronuncia correctamente

Título: Prueba de evaluación fonética (PEF). Ver Anexo # 8

Objetivo: Comprobar la evaluación fonética mediante el uso de tarjetas.

Materiales: láminas, tarjetas, espejo

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda realiza la actividad con un juego que se titula Pronuncia correctamente, el mismo consiste en que se presentan láminas de diferentes sonidos. En esta actividad se propone un grupo de tarjetas especìficas (ver Anexo # 8) para evaluar espontánea y no espontánea la pronunciación, se estimula al educando y se recoge en la exploración según pronuncie las palabras.

Ejercicios de pronunciación

Estos ejercicios el logopeda debe realizarlos de forma individual, mostrándole al escolar la posición articulatoria correcta, para pronunciar el fonema adecuadamente. Estos ejercicios deben ser de cierta duración para evitar que se fatigue.

En los ejercicios de articulación es de gran utilidad, generalmente, el empleo de sonidos auxiliares que sea capaz de pronunciar correctamente y a partir de ellos podemos llegar a la obtención de los nuevos fonemas.

Ejercicios de ritmo unidos a la articulación

Utilizar articulaciones que el niño ya domina, se pueden realizar ejercicios de ritmo que facilitarán la interiorización de las articulaciones y su expresión, por ejemplo:

a) Ta Ta Ta To Ta Ta

b) Pa Pa Pa Po Pa Pa

Se pueden hacer diversas combinaciones que el niño ya domina y seguirlas a distintas velocidades con las articulaciones que interese trabajar.

Ejercicios para utilizar el ritmo como medio de automatización de la articulación correcta.

El ritmo es un medio idóneo para integrar la articulación correcta en el lenguaje espontáneo del niño, ya que permite flexibilizar los movimientos que se precisan para la articulación correcta de cada sonido, por ejemplo:

Se pueden utilizar sencillas estructuras rítmicas: Ca ca ca ca ca ca o bien sa sa sa sa sa sa o utilizar el fonema en sílabas directas e inversas dentro de una misma estructura sa sa sa as as as sa sa saLa la la al al al la la la

Trabajar sonidos que comprende para que aprenda a discriminarlos: tra tra tar tar tra tra tar tar.

La combinación del fonema trabajado con diferentes vocales puede ser de utilidad por las ligeras transposiciones del punto de articulación que a veces se dan:

ra ra ra ri ra ra ra re

Evaluación: Se invita al niño que repita varias veces los sonidos.

Actividad: # 11

Título: Juegos para la automatización de sonidos.

Juego # 1. Nombre: " La pelota en el aire."

Objetivo: Repetir palabras con los sonidos /r/ /s/ /l/ /k/ y /j/ correctamente.

Materiales: Pelota, cuerda, cartón o cartulina.

Método: Ilustrativo- demostrativo

Forma de ejecución:

Formar dos equipos A y B, cada uno puede tener tantos jugadores como estime en que dirige.

Con una raya se marca el sitio donde deben colocarse los jugadores, alternando uno por cada equipo.

Se coloca una cuerda entre dos palos, a una distancia prudencial entre la línea de salida y unos cuadrados de cartones de diferentes colores: rojo, azul, y verde que estarán parados al frente.

A la orden del logopeda el primer niño de cada equipo lanzará la pelota por encima de la cuerda y tratará de dar en uno de los cuadrados que tiene al frente.

Al dar en uno de ellos debe realizar el ejercicio que el logopeda señale:

a) Observa la lámina y descríbela.

b) Repite palabras con r, s, l, k, j y directas dobles con r.

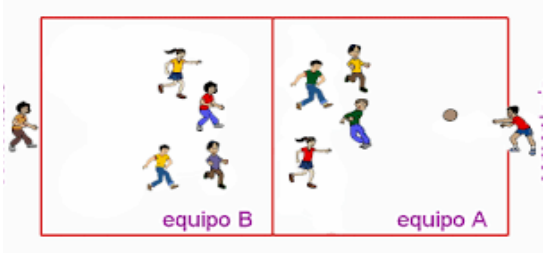
c) Localiza un sonido dentro de una palabra (los más afectados en la pronunciación).

d) Busca otras palabras que lleven ese sonido.

e) Diga palabras con un sonido determinado y explica qué es.

f) Cada jugador tiene derecho a tirar tres veces. Reglas: Se anotan los tantos al equipo de acuerdo con la respuesta del jugador, de no poder responder él solo, se pide ayuda a un niño del otro equipo, gana el equipo que más tantos acumulen.

El logopeda controla de forma individual la respuesta de cada jugador.



Juego # 2.

Nombre: " En un barco marinero."

Objetivo: Pronunciar correctamente palabras con el sonido que seleccione el logopeda

Materiales: Pañuelos.

Método: Demostrativo

Forma de ejecución:

Invitar a los niños a escuchar una ronda: En un barco marinero hay un letrero que dice: "Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver" Tiro mi pañuelo al suelo y tú lo vas a recoger.

Preguntar:

a) ¿De quién se habla?

b) ¿Qué sabemos del mar y de los barcos?

Se analiza la ronda y se explica.

Se trabaja por partes para, memorizarla.

Luego se invita a los niños a jugar.

Se forman en círculos y cantan la canción girando.

En el centro estará un niño o una niña bailando al compás de la canción, con un pañuelo, que será la reina o rey de los mares en ese momento. Cuando la canción lo indique dejará caer el pañuelo delante de uno de los compañeros que participan en el juego, el cual deberá decir una palabra que tenga el sonido que se esté trabajando y que no aparezca en la ronda.





Gana y ocupa el centro de la ronda el niño que diga la palabra con el sonido, convirtiéndose así en el rey o la reina de los mares.

Evaluación: Durante toda la actividad se evalúa la calidad de la pronunciación y se estimula los progresos que el niño vaya obteniendo.

Actividad: # 12

Título: Reconocimiento de las sílabas directas del fonema /s/.

Objetivo: identificar sílabas directas dobles del fonema objeto de estudio

Distinguir imágenes y texto escritos por diferentes documentos impresos del entorno.

Materiales: Láminas con los fonemas /s/

Métodos: Demostrativo

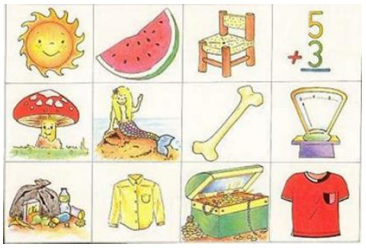
Forma de ejecución:

Se le pedirá al niño que repita filas seguidas de vocales, luego coloque las vocales antes de los silbidos (asss, esss, isss, osss y usss) y finalmente inserte los silbidos entre las vocales (asssá, essssé...) Podemos usar la siguiente tabla para este ejercicio. Se solicitará al niño repetir series acompañadas de vocales (sa, se, si…), y luego se intercalará los silbidos entre vocales y acentuando las últimas. Sssssssssssá; sssssssssssé; ásssssssssss; asssssssssssá



Se le procederá a entregar a cada niño una lámina donde tiene que observar que contiene esta, luego se le pedirá que relacione el fonema /s/ con las vocales y forme las sílabas directas y por último, relacione la sílaba formada con la imagen. Después de esa actividad se les indicará que deben encontrar el tesoro del fonema /s/ para eso se encontrará imágenes dispersa dentro del aula, donde ellos deberán buscar y una vez que encuentren todas las imágenes la actividad se terminará.

Consolidación: Después de esa actividad se realizará la **loteria del fonema** s, donde cada escolar tendrá una tabla con imágenes relacionada de dicho fonema para eso la docente deberá ir nombrando objetos que tengan el fonema /s/ y los niños tendrán que colocar un maíz o una piedra si tienen el objeto que mencionó el logopeda, para esta podemos trabajar lo que es de forma horizontal, vertical o la tabla llena el que logre completar ya sea de forma horizontal, vertical o tabla llena recibirá un premio.



Evaluación: Se invita al niño a pronunciar cada palabra en las láminas, identificando las sílabas trabajadas.

Actividad: # 13 

Título: La intensidad de la voz.

Objetivo: Evaluar la intensidad de la voz (Débil o fuerte)

Materiales: espejo, láminas.

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda selecciona tres puntos cada uno a una distancia de un metro, invita al educando a colocarse en el primer punto y así sucesivamente hasta llegar el punto tres, donde va ir conversando (del eje temático que el logopeda va a trabajar). Luego le orienta que debe ir aumentando siempre la intensidad a medida que va hacia los puntos dos y tres. Así el logopeda va a escuchar la intensidad de la voz, si es débil o fuerte.

Evaluación: Se le orienta al niño observar una lámina seleccionada por el logopeda y pronunciar las palabras aumentado o disminuyendo la intensidad de la voz según se requiera.

Actividad: # 14

Título: La voz más bonita.

Objetivo: evaluar el tono de la voz.

Materiales: espejo

Método: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de ejecución: El logopeda invita al educando a tomar la mayor cantidad de aire posible, manteniendo el pecho erguido. Luego invita a realizar una inspiración nasal suave, alargando un sonido neutro, largo y mantenido sin variar el hilo de la voz. Él logopeda registra las características tono del educando (si es agudo, ronco, débil).

Evaluación: oral

Actividad: # 15

Título: La respiración correcta.

Objetivo: evaluar la respiración.

Materiales: espejo,

Métodos: demostrativo

Responsable: logopeda

Forma de Ejecución: En este tipo de actividad el logopeda trabaja con los siguientes aspectos

-Inspiración: registra la forma en que se realiza: si es nasal, bucal, si tiene obstrucción nasal, silenciosa, ruidosa, etc.

-Forma de respiración: Él logopeda se pondrá despalda al educando y va ir desplazando las manos, apoyando sólo los dedos pulgares, a lo largo de toda la columna desde el cuello hasta la cintura, comprobando en qué lugar tiene un desplazamiento lateral de las manos. Se consignará si es clavicular, costal o abdominal. Siempre recordando que la adecuada para el habla es la costo diafragmática.

Evaluación: Se le solicita al niño demostrar varias veces la inspiración y espiración de forma correcta.



Actividad: # 1 5

Título: Cómo preparo mis órganos articulatorios.

Objetivo: Evaluar la cavidad bucal y su funcionamiento en el educando rinolálico.

Materiales: espejo

Métodos: demostrativo.

Responsable: logopeda

Forma de Ejecución: la logopeda realizará la actividad profundizando en los siguientes aspectos del aparato articulatorios.

- Oclusión mandibular: Determinaremos si existe mordida abierta.
- Implantación dentaria: Si presenta una separación excesiva entre los dientes, apiñamiento, retroversión.
- Labios: se determina la presencia de labio leporino o fisura del labio superior, parálisis labial.
- Paladar duro y funcionalidad del velo: se observa la conformación ósea del paladar duro.
- Lengua: si existe macroglosia, microglosia

Posteriormente se invita al niño a realizar ejercicios con los labios, lengua, mandíbula y mejillas de forma repetida.

Sugerencias de ejercicios para mejillas y labios:

1. inflación de ambas mejillas al mismo tiempo;
2. inflar las mejillas alternativamente;
3. retracción de las mejillas en la cavidad bucal entre los dientes;
4. movimientos de succión: la probóscide empuja los labios cerrados hacia adelante y luego regresan a su posición normal (las mandíbulas están cerradas);
5. sonrisa: los labios están fuertemente estirados hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, exponiendo ambas filas de dientes;
6. sonrisa con apertura y cierre de la boca, cierre de los labios;
7. estirar los labios con un embudo ancho con las mandíbulas abiertas;
8. estirar los labios con un embudo estrecho (imitación de un silbato);
9. retracción de los labios en la boca con presión apretada sobre los dientes con las mandíbulas bien abiertas;
10. imitación de enjuague de dientes (el aire presiona con fuerza los labios);
11. vibración de los labios;
12. movimiento de los labios con la probóscide izquierda-derecha;
13. movimientos de rotación de los labios con la probóscide;
14. fuerte hinchazón de las mejillas (los labios retienen aire en la cavidad bucal).

Sugerencias de ejercicios a realizar con la lengua:

1) sacando la lengua con una pala;
2) sacar la lengua con una picadura;
3) protrusión de una lengua aplanada y puntiaguda alternativamente;

4) girar una lengua que sobresale fuertemente hacia la derecha y hacia la izquierda;
5) subir y bajar la parte posterior de la lengua: la punta de la lengua descansa sobre la encía inferior, y luego la raíz sube y luego cae;
6) succión de la parte posterior de la lengua al paladar, primero con las mandíbulas cerradas y luego con las abiertas;
7) la lengua ancha que sobresale se cierra con el labio superior y luego se introduce en la boca, tocando la parte posterior de los dientes superiores y el paladar y doblando su punta hacia arriba en el paladar blando;
8) succión de la lengua entre los dientes, de modo que los incisivos superiores "raspen" la parte posterior de la lengua;
9) lamedura circular con la punta de la lengua de los labios;
10) subir y bajar una lengua ancha que sobresale hacia los labios superior e inferior con la boca abierta;
11) doblar alternativamente la lengua con un aguijón hacia la nariz y el mentón, los labios superior e inferior, los dientes superiores e inferiores, el paladar duro y la parte inferior de la cavidad bucal;
12) tocar los incisivos superiores e inferiores con la punta de la lengua con la boca bien abierta;
13) sostenga la lengua sobresaliente con una ranura o un bote;
14) sostenga la lengua que sobresale con una taza;
15) morder los bordes laterales de la lengua con los dientes;
16) apoyando los bordes laterales de la lengua contra los incisivos laterales superiores, con una sonrisa, suba y baje la punta de la lengua, tocando las encías superior e inferior;
17) con la misma posición de la lengua, tamborilear repetidamente con la punta de la lengua sobre los alvéolos superiores (t-t-t-t-t);

Evaluación: Se invita al niño a realizar espontáneamente los ejercicios que anteriormente le demostramos

Actividad: # 16

Título: Actividades para ejercitar la motricidad articulatoria**.**

Objetivo: Estimular la motricidad labio- lingual en los escolares rinolálicos

Materiales: El propio cuerpo del niño

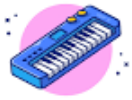
Métodos: Demostrativo

Responsable: Logopeda

Forma de ejecución:

¡Saca la lengua!: Una buena idea para trabajar la motricidad labio-lingual es decirle al pequeño que su cara es una casita, en la que los ojos son ventanas, la nariz el timbre, la boca la puerta y la lengua un amigo que está dentro de ella. Este juego permite entrenar los movimientos. Para ello, hay que pedir al niño que llame al timbre, abra la puerta y que deje salir (y volver a entrar después) a su amigo para dar un paseo.

La orquesta: Este juego permite relacionar el lenguaje gestual con el oral a través de los sonidos. En este caso, será la música la que estimule el habla del niño. El logopeda enseña al pequeño los diferentes sonidos de los instrumentos musicales a la vez que realiza el gesto que le corresponde (simula que los toca). Así, el tambor será pon, pon, pon, la trompeta pa, pa, pa y la guitarra ran, ran, ran. El pequeño debe identificar cada gesto y responder con la onomatopeya correspondiente.



Evaluación: Se le invita al niño a repetir varias veces el ejercicio.

Actividad: # 17

Título: Juegos para reforzar el lenguaje del niño

Objetivo: Desarrollar la expresión oral en el niño rinolálico.

Materiales: Láminas, frutas, juguetes ilustrativos con animales, entre otros.

Método: Ilustrativo- demostrativo

Responsable: Logopeda

Forma de ejecución

¿Qué hay ahí?: Un cuento con ilustraciones para niños, una lámina o una revista servirán para ayudar al pequeño a ampliar el vocabulario. El juego consiste en contemplar juntos las imágenes y pedirle que señale y enuncie lo que ve en ellas. Cuando no pueda nombrar alguna de las cosas que observa, el logopeda debe decirle qué es y hacerle una breve descripción. Luego pedirle al niño que repita. Se apoyará la descripción en preguntas, las que graduará el nivel de complejidad de acurdo a las posibilidades del niño.

El tren de las palabras: «Llevo un vagón de… (fruta, animales, colores, etc)». A partir de esta frase el niño y el logopeda empiezan a llenar el tren con palabras de la familia elegida. El adulto puede

incorporar las menos usuales para que el pequeño pueda participar de forma activa en el juego, a la vez que aprende nuevas palabras.





Veo, veo: Este clásico juego enseña al niño a describir cosas y le ayuda a desarrollar vocabulario. El menor (o el logopeda) elige un objeto que esté a la vista y comienza a dar pistas, entre ellas, su color, la letra por la que empieza o su situación. El turno termina cuando el otro jugador adivina qué es.



Evaluación: se observa y evalúa los progresos del niño y se estimulará sistemáticamente.

Epígrafe 4: Valoración de la pertinencia, factibilidad y efectividad del Folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.

Para realizar la valoración de la factibilidad de la aplicación del folleto de actividades para el diagnóstico del componente sonoro del lenguaje fue necesario transitar por un primer momento, la selección de los especialistas teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

-Ser graduado universitario.

-Disposición para participar en la evaluación del folleto de actividades.

- Años de experiencia profesional.

-Nivel de conocimiento sobre la patología rinolalia

Desde el inicio de la investigación se estableció una estrecha comunicación con especialistas que, por su grado de acercamiento y experiencia acumulada, aportaron elementos importantes para conocer los problemas y necesidades en relación con el tema que se trate.

Una vez elaborado el folleto, se procedió a la selección de los especialistas (ver anexo 9) que pudieran ofrecer criterios valorativos en cuanto a su pertinencia y factibilidad, en función del objetivo de la investigación. Los criterios tenidos en cuenta para su selección fueron:

-Experiencia profesional, en la ejecución del trabajo de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje.

-Categoría docente y científica.

-Conocimiento de las concepciones sobre la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educando con rinolalia.

-Consulta de trabajos relacionados con el tema que se investiga.

Para efectuar la evaluación por parte de los especialistas, se seleccionaron un total de 14 especialistas, los cuales poseen vasta experiencia en el trabajo de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educando con rinolalia y los conocimientos poseen en materia de atención logopédica en dicho componente, dentro de ellos se encuentran: 9 especialistas en Logopedia, 2 Doctores en Ciencias de la Educación, 3 directivo educacional.

El 100 % de los especialistas encuestados han demostrado poseer la experiencia profesional sobre la temática que se investiga, se han desempeñado en diversos cargos y conocen a profundidad el trabajo del maestro logopeda desde sus propias vivencias, y han sido protagonistas en el desarrollo de estos educandos, todo ello ha favorecido la precisión y profundidad en los diferentes análisis realizados y una mirada con enfoque especializado a la problemática objeto de estudio.

Los mismos, tienen como promedio 10 años de experiencia profesional, el 50% posee conocimientos acerca de las concepciones del componente sonoro del lenguaje y el otro 50% posee experiencia en la ejecución de exploraciones logopédicas a educando con rinolalia y el diagnóstico de este trastorno del Lenguaje.

El 10% poseen el grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, el 20% son Máster y el 50% ostentan el título que los acredita como licenciados. En total, el 50% de ellos poseen importantes categorías docentes.

Para evaluar el nivel de conocimiento respecto al tema de investigación, se propuso una escala del 1 al 5, siendo el 1 el valor más bajo y el 5 el más alto, lo cual reveló que el 80% de los especialistas encuestados, posee un conocimiento sobre la temática en cuestión.

Se les hace entrega del folleto de actividades propuestas, para su correspondiente estudio, análisis y establecimiento de opiniones pertinentes para valorar su pertinencia y factibilidad; así como para su perfeccionamiento oportuno.

En el segundo paso, se desarrolla la ronda de intercambio con los especialistas en la que se hizo entrega, previamente, del folleto de actividades y su fundamentación, con el objetivo de conocer y examinar los criterios, valoraciones y recomendaciones, al respecto; para lo cual se tuvieron en cuenta los indicadores:

-Novedad del folleto de actividades.

-Pertinencia y factibilidad del folleto de actividades.

-Correspondencia entre el folleto de actividades y su relación con las exigencias del trabajo del logopeda con educandos con rinolalia según las exigencias del Tercer Perfeccionamiento Educacional cubano.

-Pertinencia de los presupuestos teóricos para sustentar la concepción del folleto de actividades propuesto

-Relación entre el objetivo general del folleto de actividades y su contenido para la aplicación en la atención logopédica.

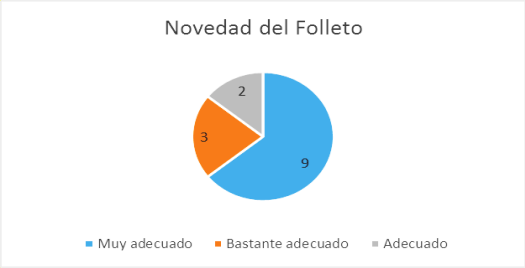
-Necesidad de implementar el folleto de actividades como parte del trabajo del trabajo metodológico del logopeda.

-Adecuación a las necesidades de preparación del logopeda en materia de atención logopédica al educando con rinolalia.

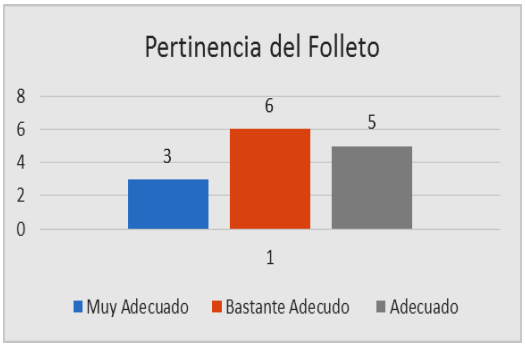
Para la selección inicial se envió la primera encuesta a un total de 14 especialistas con conocimiento del tema.

Los resultados que a continuación se revelan, son resultado del análisis del intercambio con los especialistas:

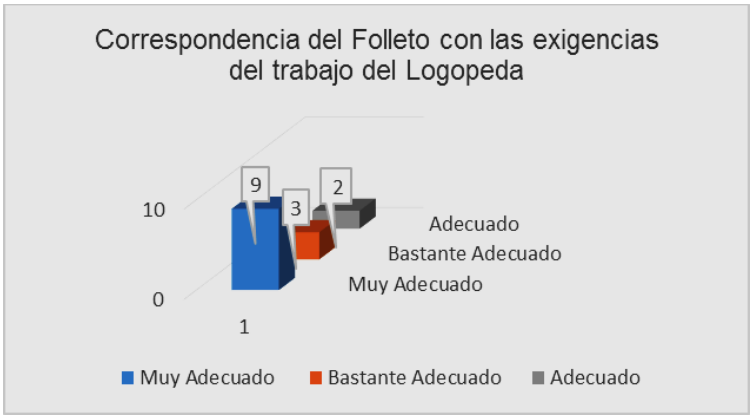
De los 14 especialistas consultados, 9 (64,28 %) consideran Muy Adecuado el indicador relacionado con la novedad del folleto de actividades, 3 (25 %) lo considera Bastante Adecuado, mientras que, 2 (16.6 %) lo valoran de Adecuado.



Respecto al indicador pertinencia de la propuesta de folleto de actividades, 3 (21.4 %), lo consideran Muy Adecuado, 6 (42,85 %) alegan que es Bastante Adecuado y 5 (35,71%) refieren que es Adecuado.



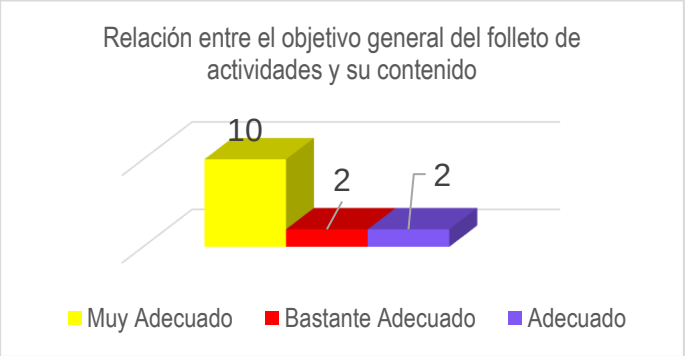
Por su parte, el indicador correspondencia entre el folleto de actividades y su relación con las exigencias del trabajo del logopeda en la atención logopédica de educandos con rinolalia según las exigencias del Tercer Perfeccionamiento Educacional cubano, es considerado Muy Adecuado por parte de 9 (64,28 %) y Bastante Adecuado, por 3 (21,42%) de ellos y los 2 restantes (14,28%) lo consideran Adecuado.



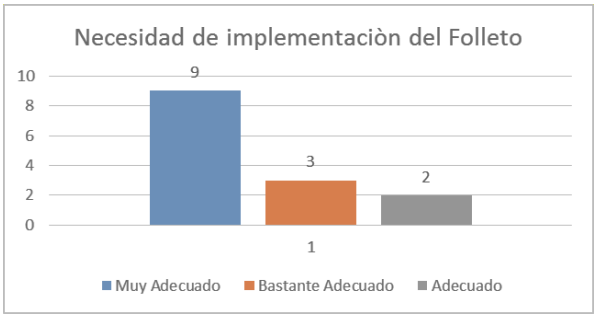
En el indicador selección de los presupuestos teóricos para sustentar la concepción del folleto de actividades propuesto, 7 (50 %) de los especialistas aportan criterios que lo definen como Muy Adecuado, en tanto 4 (28,57%) lo evalúan como Bastante Adecuado y 3 (21,42 %) lo precisan como Adecuado.



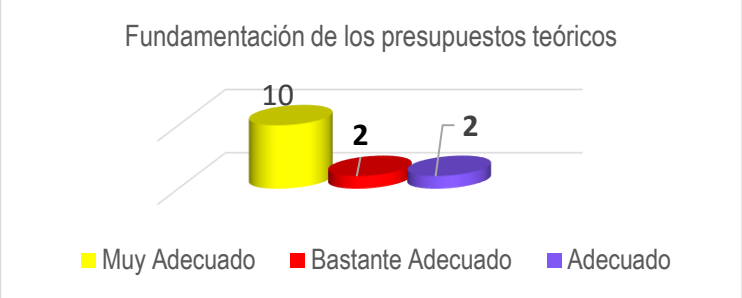
En el análisis del indicador relación entre el objetivo general del folleto de actividades y su contenido para la aplicación en la atención logopédica de educandos con rinolalia se precisa que este es considerado como Muy Adecuado por 10 (71,42%), Bastante Adecuado por 2 (14,28%) y Adecuado por 2 (14,28%).



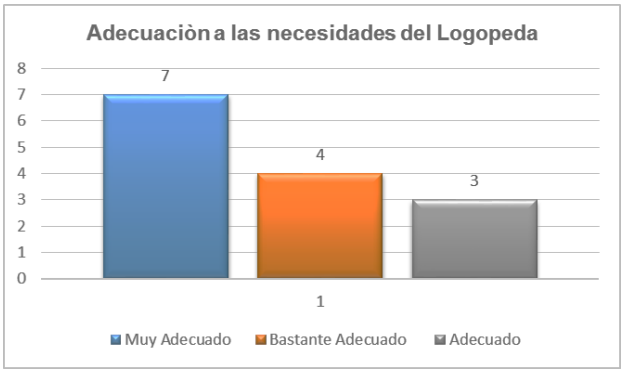
La necesidad de implementar el folleto de actividades como parte del trabajo de la atención logopédica que realiza el logopeda, fue un indicador considerado Muy Adecuado por 9 (64,28%) especialistas, Bastante Adecuado por 3 (21,42%) y Adecuado por 2 (14,28%).



Por otro lado, el indicador fundamentación de los presupuestos teóricos que sustentan la concepción del folleto de actividades es considerado Muy Adecuado por 10 (71,42%), Bastante Adecuado por 2 (14,28%) y Adecuado por 2 (14,28%).

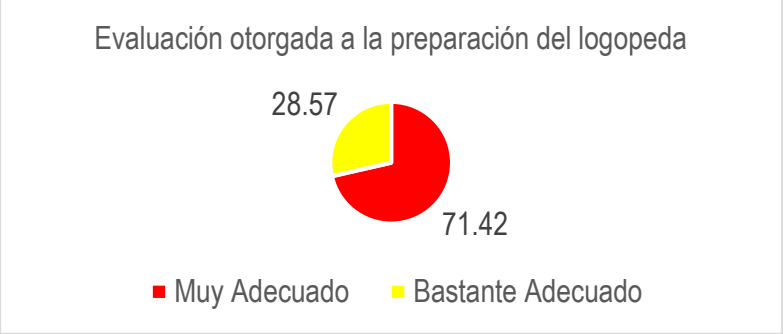


Finalmente, el indicador adecuación a las necesidades de preparación del logopeda en materia de atención logopédica al educando con rinolalia, se valora por 7 (50%) Muy Adecuado, mientras que 4 (28,5%) opinan que es Bastante Adecuado, y lo consideran Adecuado 3 (21,42 %).

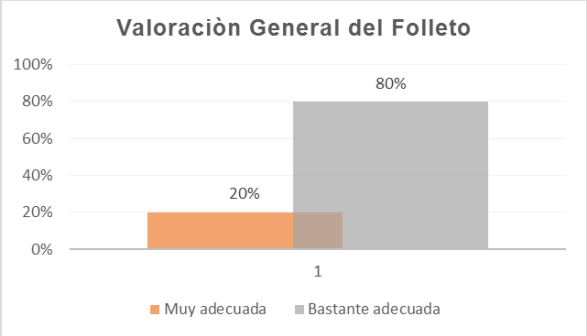


El análisis anterior permite determinar que el folleto de actividades propuesto, ha sido ampliamente aceptado por los especialistas seleccionados, quienes de manera general consideran apropiada su aplicación, teniendo en cuenta la necesidad de contribuir, desde el perfeccionamiento del proceso de atención logopédica a la preparación de esta para apoyar en su proceso correctivo-compensatorio a los educandos con rinolalia. No obstante, reconocen las limitaciones objetivas y subjetivas que pueden entorpecer la aplicación y éxito esperado con la implementación del folleto de actividades propuesto.

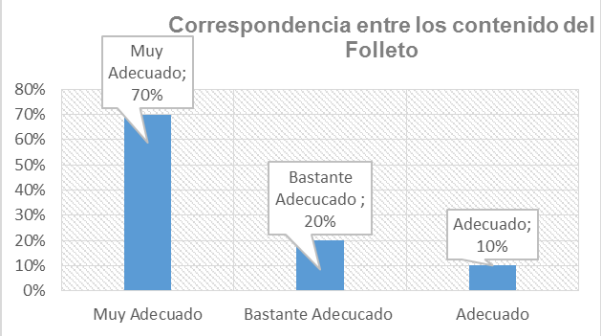
La aplicación de la encuesta a los 4 maestros logopedas, con el fin de conocer sus criterios respecto a la preparación alcanzada con la aplicación del folleto a educandos rinolálicos, arrojó como resultado que el 71,42% la consideró Muy Adecuada y el 28, 57% restante la valoró como Bastante Adecuada.



Con respecto a la evaluación de cada una de las 11 actividades propuestas, el 100 % ratificaron los mismos, considerándolos, como promedio, el 70% como muy adecuados y el 30% como bastante adecuados. Al valorarse en sentido general, el folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia, el 20% los considera bastante adecuados, mientras que el 80% los catalogó como muy adecuados.

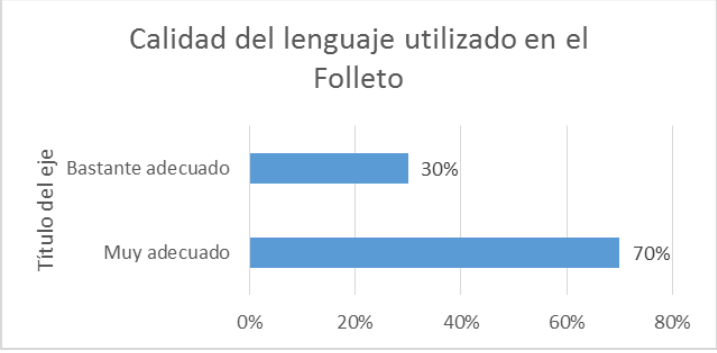


En cuanto a la correspondencia entre los contenidos de las diferentes actividades para la atención al componente sonoro del lenguaje, el 10% considera que es adecuado, un 20% bastante adecuado y un 70% valora que es muy adecuado.



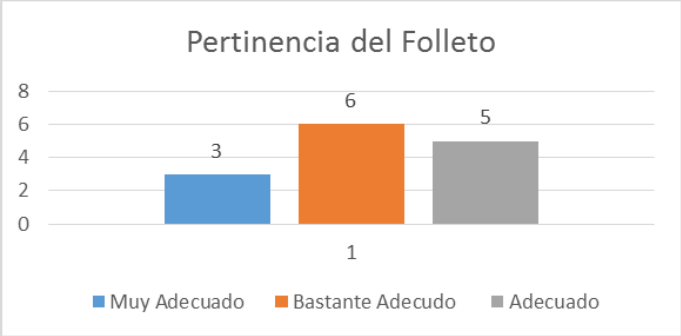
Referente al lenguaje utilizado en el folleto teniendo en cuenta las características del personal al que está dirigido, el 30% opinó que es bastante adecuado, mientras que el 70% visualiza que es muy adecuado.

Respecto a las posibilidades de preparación que permiten las orientaciones ofrecidas a lo largo del folleto, solo el 20% sugiere que es bastante adecuado, sin embargo, el 80% es del criterio que son muy adecuadas.



Satisfactoriamente el 100% ratifica la pertinencia del folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia, resultado que da cumplimiento al

objetivo de la presente investigación y que nos permite inferir que el folleto de actividades propuesto es pertinente y factible.



La totalidad de los especialistas declaran con su evaluación que es aplicable, que se corresponden con las exigencias actuales de la educación, los especialistas expresan que las actividades elaboradas contribuirán a la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje, como parte del trabajo del maestro logopeda, así como permitirá también perfeccionar el trabajo conjunto entre maestros y logopedas del territorio.

A pesar de coincidir en el valor de la propuesta se emitieron recomendaciones que facilitaran perfeccionar la misma.

•El folleto de actividades se corresponden con las necesidades de los maestros logopedas, por lo que se deben seguir implementando en las actividades metodológicas para contribuir a la preparación de los logopedas y maestros, así como todo el personal que trabajan con este tipo de educando.

•Se debe profundizar en las técnicas para el diagnóstico y evaluación del componente sonoro del lenguaje como base fundamental para un tratamiento efectivo a estos educandos.

CONCLUSIONES

La literatura consultada permitió corroborar el proceso de atención de los trastornos del lenguaje y la comunicación, enfatizando en el componente sonoro del lenguaje en educandos rinolálicos.

Los instrumentos aplicados demuestran las insuficiencias en el trabajo correctivo compensatorio con los educandos rinolálicos, donde se elaboró un folleto de actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia, sustentadas en los fundamentos del materialismo dialéctico, así como en la concepción de los postulados de la Escuela Histórico- cultural de L.S. Vygotsky.

La concepción implementación del sistema de actividades proporcionó evidencias de su valor e impactos científico y socio- educativo en torno a la atención logopédica del componente sonoro de educandos rinolálicos, cuyas manifestaciones del trastorno en el ámbito psicológico, pedagógico y social, se agudiza a partir del cuadro sintomatológico que lo caracteriza. Siendo necesario un proceso correctivo compensatorio del componente sonoro del lenguaje, eficaz, sobre la base de un diagnóstico y evaluación profunda y con técnicas novedosas favorecedora de un proceso rehabilitativo eficaz en el proceso de atención logopédica.

La valoración positiva de especialistas de la factibilidad, rigor científico y pertinencia del folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje a educando con rinolalia, justifica la validez de dicho aporte en la contribución al proceso correctivo de educandos con rinolalia.

En la práctica se pudo comprobar la efectividad del folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia fueron efectivas, pues permite al logopeda profundizar en el análisis de este componente.

RECOMENDACIONES

1-Continuar profundizando en el folleto de actividades para la atención logopédica al componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia con nuevas variantes de acciones.

2-Generalizar el folleto de actividades a otras instituciones con escolares con afectaciones en el componente sonoro del lenguaje.

Bibliografía

Arredondo Kassab, a. M., Pérez Rosales, M. L., & Crespo Moinelo, M. C. (2019). Propuesta terapéutica-pedagógica de rehabilitación fonoaudiológica para la corrección y compensación fisiológica de los trastornos que afectan la comunicación y el lenguaje en diferentes grupos etarios. *Órbita Científica*, *25* (108).

Bell, Rodríguez. R. (1992). *Convocados por la diversidad*. Editorial Pueblo y Educación.

Bell, Rodríguez. R. (1997). *Educación Especial: Razones Visión actual y desafíos*. Editorial Pueblo y Educación.

Bello, Davila, Zoe (2002). *Psicología social*. Editorial Félix Varela.

Boshovich, L. I. (1976). *La personalidad y su formación en la edad infantil*. Editorial Pueblo y Educación.

Cabanas Comas, R. (1980). *Acerca de una teoría del origen del habla en la humanidad con derivaciones terapéuticas: nueva interpretación*. Hospital Psiquiátrico de La Habana.

Calzadilla González, O. (2021). Metodología de la preparación del niño para el aprendizaje de la escritura en primer grado. *Luz*, *21* (3), 51-62.

Cárdenas Toledo, C., Martín Pérez, M., Méndez Montí, I., & Prado Alfonso, R. (1979). *Los métodos para la exploración logopédica*. Editorial de Libros para la Educación.

Castro, F¨ .Discurso pronunciado en la clausura de XIX Seminario Nacional de Educación Media, 7 de febrero de 1987, Granma.

Castro, R. (2002, 17 septiembre). Discurso pronunciado el 16 de septiembre del 2002. *Granma.*

Castro Ruz, F. (1987). Discurso pronunciado en la clausura de XIX Seminario Nacional de Educación Media. Teatro Karl Marx. 7/2/1987. In Granma (Ed.). La Habana.

Cobas Ochoa, C. L. (2010). *Temas logopédicos para los docentes*. Editorial Pueblo y Educación.

Cobas Ochoa, C. L., & Gárciga Domínguez, A. (2013). *El logopeda en la institución educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

Chernousova, L. N. (2008). *La estimulación de la comunicación verbal de los escolares con necesidades educativas especiales en el desarrollo general del lenguaje.* [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Peagógicas, "Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero"]. Holguín.

Cruz, T. L. (2006). *Psicología del desarrollo*. Editorial Félix Varela.

Diccionario de Filosofía. (1984). Editorial Progreso.

Fernández, E. (Coord.) (2012). *Memorias para un aniversario. Creación de los Círculos Infantiles en Cuba*. Editorial de la Mujer.

Fernández, G. y Rodríguez, X. (2011). *Logopedia primera parte: Texto para los estudiantes de las carreras Licenciatura en Logopedia y Educación Especial*. Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008a). *Atención a los niños con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje en Cuba.* Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008b). *La Atención Logopédica en la Edad Infantil.* Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo , G., & García Veliz, M. C. (2009). *Organización de la Atención logopédica Integral en las Instituciones Educacionales.Folleto de preparación para el maestro logopeda*. Pueblo y Educación.

Figueredo Escobar, E., Nieves Rivero, M. L., Pérez González, S., & Borges Rodríguez, S. (1984). *Logopedia. Tomo I*. Editorial Pueblo y Educación.

Franco, O. (2000). *Estimulación temprana. ¿Enfoque Nuevo de la Educación?* [CD de materiales bibliográficos para los ISP, Carrera Preescolar]

Franco, O. (2006). Lectura para educadores preescolares IV. Editorial Pueblo y Educación.

García, M.T. (2006). *Psicología Especial Tomo I, II y III*. Editorial Félix Varela.

Garetty, B. (2009). *Estimulación Temprana en los primeros años de vida.* Ministerio de Educación.

Lores Leyva, I., & Calzadilla González, O. (2013). Los trastornos de la lectura y la escritura en escolares de la Educación Primaria. *EduSol*, *13*(42), 13-23.

Martín Pérez, M., Prado Alfonso, R., & Méndez Montí, I. (1980). *Los métodos para el tratamiento logopédico*. Editorial Pueblo y Educación.

Morales, M. E. (2004). *Enfoque práctico de la Logopedia.* Editorial Pueblo y Educación. .

Nieves Rivero, M. L. (1987). Exploración Logopédica. In *Temas Logopédicos. Selección de lecturas.* (pp. 90-108). Editorial Pueblo y Educación.

Nieves Rivero, M. L. (2002). *El diagnóstico como proceso de evaluación- intervención: Una nueva concepción en la atención a las necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad.* Editorial Pueblo y Educación.

Rondal, J. A. (2000). Componentes del lenguaje y aspectos del desarrollo desde la perspectiva de la evaluación. En Masson. *Evaluación del Lenguaje*. (pp. 1-28) Barcelona, España.

Valdés, A.I. (2017). *El desarrollo de Habilidades Pedagógicas profesionales en la formación inicial del logopeda para la Atención a la Disfonía*. Tesis doctoral. Universidad de Pinar del Río

Vygotsky, L. S. (1989). *Obras Completas. Tomo V.* Editorial Pueblo y Educación.

Anexo 1.

Entrevista a Logopedas.

Objetivo: valorar las diferentes actividades que se realizan para la evaluación y diagnóstico de los educandos con rinolalia y la efectividad de estas en el proceso correctivo compensatorio.

Estimado logopeda: Se realiza una investigación sobre las diferentes actividades que se realizan para la atención logopédica de los educandos con rinolalia y la efectividad de estas en el proceso correctivo compensatorio. Teniendo en cuenta su experiencia profesional, consideramos que su opinión será de gran utilidad, por lo que solicitamos su valiosa colaboración y agradecemos la información que nos ofrece.

Datos generales del entrevistado:

Nombres y Apellidos:

Años de experiencia_____

Preguntas

1. ¿Cuáles son las diferentes actividades que usted aplica para la atención logopédica de los escolares con rinolalia?
2. ¿Considera usted suficiente las actividades diseñadas para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en los educandos con rinolalia.? Fundamente.
3. ¿Qué ventajas y limitaciones usted considera tener las actividades actuales para evaluar la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia.?
4. ¿Qué sugerencias pudiera dar para fortalecer las actividades para la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje de los educandos con rinolalia?

Anexo 2

Guía de observación a clases logopédicas.

Objetivo: constatar el desarrollo de la atención logopédica del componente sonoro de lenguaje en la atención a los educandos con rinolalia y el nivel alcanzado en dicho proceso.

Año _____ Fecha_____

Aspectos a observar:

1-Ambiente general del aula:

1. Agradable___ Motivante___ Tensionado___

Aspectos a evaluar.

-Propicia el objetivo en la clase el desarrollo de habilidades comunicativas en la atención a la rinolalia.

-Se precisan las acciones con claridad y comprueba a través de preguntas la comprensión de los educandos.

-Las actividades diseñadas responden al desarrollo del componente sonoro del lenguaje.

Anexo 3:

EXÁMEN LOGOPÉDICO DE LA ARTICULACIÓN
ELA-ALBOR

	FONEMAS	LISTA DE PALABRAS			INICIAL	MEDIA	FINAL
BILABIALES	/m/	MONO	CAMA	LAMPARA			
	/p/	PELOTA	ESPADA	STOP			
	/b-v/	BOLO	CUBO	SUBMARINO			
DENTALES	/d/	DADO	NIDO	RED			
	/t/	TORO	BOTA	ROBOT			
	/z/	ZAPATO	LAZO	PEZ			
LABIODENTALES	/f/	FOCA	ELEFANTE				
ALVEOLARES	/s/	SILLA	MESA	VELAS			
	/l/	LUNA	PALA	SOL			
	/n/	NARIZ	MANO	PAN			
	/r/	PERA	ARBOL	TENEDOR			
	/rr/	RUEDA	RATÓN	PERRO			

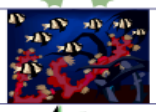
	FONEMAS	LISTA DE PALABRAS			INICIAL	MEDIA	FINAL
PALATALES	/ch/	CHUPETE	CUCHARA				
	/ll/	GALLETA	PAYASO				
	/ñ/		NIÑA				
VELARES	/k/	CAMPANA	PICO	CARACOL			
	/g/	GATO	TORTUGA				
	/j/	JIRAFA	OJO	RELOJ			
	/x/	XILOFONO	TAXI				

Anexo # 4. Prueba de articulación de fonemas

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA (sin mirar al examinador)	
Dificultad de percepción Confusión de sonidos	Pronuncia: - ad – ab - eb – ep - is – iz - er – el - om – on - es – ez - fi –ci - ac – ga - tino – fino - torre – corre - pida – pila - lecho – techo - pito – mito - limo – rimo - milla – pilla - mulo- bulo - maza – baza - piña – viña - mana – nana - llueve – nueve - tomo – como - tanta – canta - gato – cato - ceso – seso - valor – calor - arde – arte - dicho – bicho
DISCRIMINACIÓN FONÉTICA (mirando al examinador)	
Confusiones de los fonemas	- ad – ab - eb – ap - is – iz - er – el

	- om – on - es – ez - fi –ci - ac – ga - et - ed - tino – fino - torre – corre - pida – pila - lecho – techo - pito – mito - limo – rimo - milla – pilla - mulo- bulo - maza – baza - piña – viña - mana – nana - llueve – nueve - tomo – como - tanta – canta - gato – cato - ceso – seso - valor – calor - arde – arte - dicho – bicho - mueve – nueve

DISCRIMINACIÓN FONÉTICA DE DIBUJOS

		rana – rama	
		coral – corral	
		fresa – presa	
		beso – peso	
		besa – pesa	

Anexo # 5

Hoja de Registro Prueba de Evaluación Fonética (PAF)				
Alumna/o:				
Edad:			Fecha:	Curso:
	Nº	**Palabras**	**Espontáneo**	**Repetido**
3 años	1	manzana		
	2	pie		
	3	niña		
	4	biberón		
	5	queso		
	6	foca		
	7	guantes		
	8	jamón		
	9	techo		
	10	teto		
	11	leche		
	12	jugo		
	13	sofá		
	14	avión		
	15	fuego		
	16	perfume		
4 años	18	tenedor		
	19	llorar		
	20	flecha		
	21	coliflor		
	22	playa		
	23	soplar		
	24	blanco		
	25	ombligo		
	26	clase		
	27	chicle		
	28	globo		

	29	Regla		

5 años	30	peso		
	31	peine		
	32	autobús		
	33	jaula		
	34	bailarina		
	35	ciudad		
	36	pingüino		
	37	brazo		
	38	libro		
	39	fresa		
	40	cofre, disfraz		
	41	medalla		
	42	comprar		
	43	siper		
	44	escribir		
	45	granja		
	46	cangrejo		
	47	tren		
	48	monstruo		
	49	dragón		
	50	cocodrilo		
6-7 años	51	telaraña, araña		
	52	regalo		
	53	guitarra		
	54	tortuga		
	55	ventilador		

Anexo 8

Entrevista para la selección de los especialistas

Objetivo: Constatar el conocimiento y la experiencia que poseen los especialistas acerca de la temática investigada.

Estimado(a) colega: Se está realizando una investigación acerca de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje en educandos con rinolalia usted ha sido seleccionado como posible especialista para enriquecerla, a partir de su valoración crítica y sus sugerencias. De manera que se solicita una autoevaluación de sus conocimientos relacionados con el tema que será motivo de enjuiciamiento.

Agradecida por su valiosa cooperación.

Nombre: _____
Nivel académico_____
Especialidad: _____
Grado científico: _____
Centro de Trabajo: _____
Ocupación: _____
Años de experiencia laboral en el ámbito educacional: _____

1- Participación como especialistas en alguno de los siguientes centros:

Programa Educa a tu Hijo ____

Círculo Infantil____

Universidad de Oriente____

Centro de Diagnóstico y Orientación____

2- ¿Conoce sobre la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje?

SI____ NO____

En caso de SI especifique _____

3- Años de experiencia____

4-En una escala del 1-5, considerándose el valor más alto el 5, defina el nivel de conocimiento que posee sobre la temática que se aborda en la presente investigación, marcando con una x donde corresponde.

Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Nivel de conocimiento					

6- Disposición para formar parte del equipo de evaluación del folleto de la atención logopédica del componente sonoro del lenguaje.

¿Está de acuerdo? Sí___ No___

Agradecemos su colaboración.

Anexo # 9

Guía de encuesta a aplicada a los especialistas después de recibir el folleto de actividades.

Indicadores	MA	BA	A	PA	NA
1. Novedad del folleto de actividades.					
2. Pertinencia del folleto de actividades.					
3. Correspondencia entre el folleto de actividades y su relación con las exigencias del trabajo del logopeda en educandos con rinolalia según las exigencias del Tercer Perfeccionamiento Educacional cubano.					
4. Selección de los presupuestos teóricos para sustentar la concepción del folleto de actividades propuesto**.**					
5. Relación entre el objetivo general del folleto de actividades y su contenido para la aplicación en la atención logopédica.					
6. Necesidad de implementar el folleto de actividades como parte del trabajo del trabajo metodológico del logopeda.**.**					
7. Fundamentación de los presupuestos teóricos que sustentan la concepción del folleto de actividades.					
8. Adecuación a las necesidades de preparación del logopeda en materia de atención logopédica al educando con rinolalia.					